

Buku Referensi

MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA PASIEN GANGGUAN TIDUR

Anggia Astuti
Nuridha Fauziyah



BUKU REFERENSI MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA PASIEEN GANGGUAN TIDUR

Anggia Astuti, S.Kp., Ners., M.Kep
Nuridha Fauziyah, S.Kep., Ners., M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA PASIEN GANGGUAN TIDUR

Penulis: Anggia Astuti, S.Kp., Ners., M.Kep

Nuridha Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-99-9

Cetakan Pertama: September, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi ini yang berjudul **“Manajemen Keperawatan pada Pasien Gangguan Tidur”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kualitas tidur dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, khususnya pada pasien yang menjalani perawatan keperawatan.

Gangguan tidur merupakan masalah yang seringkali terabaikan namun memiliki dampak signifikan terhadap proses penyembuhan, kualitas hidup, dan beban pelayanan kesehatan. Dalam konteks keperawatan, pemahaman yang mendalam mengenai manajemen gangguan tidur menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh perawat dalam memberikan asuhan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien.

Buku ini disusun secara sistematis dengan mengangkat empat aspek utama dalam penanganan pasien dengan gangguan tidur. Bab pertama mengulas berbagai strategi keperawatan untuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, yang merupakan langkah preventif sekaligus promotif dalam menciptakan kondisi fisiologis yang mendukung tidur. Bab kedua membahas pentingnya edukasi kepada pasien tentang kebiasaan tidur sehat, sebagai upaya empowering pasien dalam mengelola kebiasaan tidur yang adaptif dan berkelanjutan.

Bab ketiga memperluas cakupan pada pendekatan psikososial melalui dukungan psikologis kepada pasien dengan gangguan tidur kronis, karena gangguan tidur kerap kali berkaitan erat dengan stres, kecemasan, dan gangguan emosi lainnya. Terakhir, Bab keempat menekankan pentingnya kolaborasi tenaga medis dalam pengelolaan pasien dengan gangguan tidur, yang menuntut keterpaduan peran perawat, dokter, psikolog, dan profesional kesehatan lainnya dalam menciptakan intervensi yang komprehensif.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinis, pendidik, dan peneliti dalam bidang keperawatan, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan khususnya dalam penanganan gangguan tidur. Akhir kata, penulis menyampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun intelektual dalam proses penulisan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I STRATEGI KEPERAWATAN UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN TIDUR YANG NYAMAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tidur.....	2
C. Manfaat Tidur.....	2
D. Fisiologi Tidur.....	4
E. Tahapan Tidur	5
F. Faktor yang Mempengaruhi tidur.....	6
G. Dampak Kekurangan Tidur.....	10
H. Lingkungan yang Nyaman	10
I. Strategy Keperawatan dalam Meciptakan Lingkungan Tidur yang Nyaman.....	11
J. Penutup	17
Referensi.....	18
 BAB II EDUKASI PASIEN TENTANG KEBIASAAN TIDUR SEHAT	20
A. Pendahuluan.....	20
B. Konsep dan Prinsip Dasar Kebiasaan Tidur Sehat (Sleep Hygiene).....	21
C. Identifikasi Kebutuhan Edukasi Pasien.....	23
D. Strategi Edukasi Efektif dalam Mengajarkan Kebiasaan Tidur Sehat.....	25
E. Intervensi Berbasis Bukti dalam Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat.....	27
F. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat.....	29
G. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat.....	31
H. Cara Mudah untuk Tenaga Keperawatan dalam Edukasi Tidur Sehat.....	32
I. Implikasi Praktik Keperawatan	34
J. Penutup	36
Referensi.....	38
 BAB III DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK PASIEN DENGAN GANGGUAN TIDUR KRONIS.....	40
A. Pendahuluan.....	40
B. Gangguan Tidur.....	41
C. Faktor yang Mempengaruhi Gangguan Tidur.....	42

D. Klasifikasi Gangguan Tidur	42
E. Dampak Gangguan Tidur.....	44
F. Dukungan Psikologis	45
G. Prinsip Pelaksanaan Dukungan Psikologi	46
H. Faktor Psikologis Dan Sosial Yang Mempengaruhi Keadaan Psikologis Seseorang	47
I. Faktor Pendorong Pemberian Dukungan Psikologis	48
J. Bentuk Dukungan Psikologis.....	48
K. Sumber Dukungan Psikologis	49
L. Hubungan Dukungan Psikologis Dengan Gangguan Tidur Kronis	51
M. Penutup	51
Referensi.....	53

BAB IV KOLABORASI TENAGA MEDIS DALAM PENGELOLAAN PASIEN DENGAN GANGGUAN TIDUR..... 55

A. Pendahuluan.....	55
B. Prinsip-Prinsip Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Gangguan Tidur.....	56
C. Identifikasi Peran Masing-masing Tenaga Medis dalam Tim Kolaboratif.....	58
D. Model dan Strategi Kolaborasi dalam Praktik Klinik Gangguan Tidur	60
E. Komunikasi Efektif dalam Tim Kolaboratif.....	62
F. Evaluasi Efektivitas Kolaborasi dalam Pengelolaan Gangguan Tidur.....	64
G. Tantangan dalam Kolaborasi Interprofesional pada Pengelolaan Gangguan Tidur	66
H. Implikasi Praktik Keperawatan Gangguan Tidur.....	69
I. Penutup	71
Referensi.....	74

Profil Penulis.....	77
Sinopsis Buku	78

BAB I

STRATEGI KEPERAWATAN UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN TIDUR YANG NYAMAN

A. Pendahuluan

Setiap individu memerlukan waktu untuk beristirahat dan tidur guna menjaga kondisi kesehatan tetap optimal (Devi dan Heri, 2021). Istirahat dan tidur termasuk dalam kebutuhan dasar yang penting bagi seluruh manusia. Rata-rata orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 6 hingga 8 jam setiap harinya (Widiyati dkk., 2023). Sebagai makhluk yang terus beraktivitas, manusia memerlukan istirahat yang cukup untuk mengembalikan energi dan kebugaran tubuh (SAFRUDIN dkk., 2023). Kekurangan istirahat dan tidur dapat mengakibatkan penurunan kemampuan dalam berkonsentrasi, mengambil keputusan, serta keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari (Karna dkk., 2023).

Lingkungan memainkan peranan yang penting dalam kualitas istirahat tidur seseorang. Secara khusus, faktor lingkungan seperti cahaya/iluminasi, kebisingan, kelembaban, suhu udara, suhu radiasi, kualitas udara kamar tidur, dan konsentrasi karbon dioksida memengaruhi tidur seseorang, seperti durasi dan kualitas. Selain itu, karakteristik lingkungan sekitar, seperti keamanan, tingkat kebisingan, kerugian lingkungan sekitar, kemudahan berjalan kaki, tujuan keterlibatan sosial, persimpangan jalan, dan kepadatan populasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan berbagai hasil tidur, seperti durasi, waktu, dan kualitas juga. Kondisi perumahan seperti lingkungan struktural rumah, kepadatan rumah tangga, dan berbagai tempat tidur memengaruhi durasi dan kualitas tidur, serta gangguan tidur, seperti insomnia (Grandner dkk., 2022).

Perawat memegang peranan krusial dalam membantu pasien mengatasi gangguan tidur melalui berbagai intervensi keperawatan yang diterapkan. Upaya intervensi tersebut meliputi pengaturan lingkungan, peningkatan kenyamanan dan relaksasi, serta pelaksanaan promosi kesehatan. Strategi intervensi ini dinilai cukup efektif dalam menangani permasalahan tidur pada pasien (Nuramalia dan Kuntarti, 2017).

B. Tidur



Gambar 1. 1 Istirahat dan Tidur

Sumber: <https://www.capitallife.co.id/media/detil/59/5-cara-memperbaiki-kualitas-tidur>

Tidur berasal dari bahasa latin somnus yaitu periode recovery pada kerja fisiologis organ tubuh. Jadi tidur merupakan suatu kondisi terjadinya penurunan aktivitas organ tubuh atau disebut dengan fase istirahat dan hilangnya kesadaran (unconscious) melalui beberapa siklus. Sedangkan Istirahat merupakan suatu kondisi dalam keadaan tenang, rileks baik mental maupun fisik tanpa ada beban emosional, dengan kondisi perasaan menjadi lebih segar dan nyaman (Erlin Ifadah dkk., 2024).

Tidur adalah suatu kondisi tidak sadar yang ditandai dengan menurunnya respons dan persepsi individu terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan bisa sampai hilang sepenuhnya. Kondisi ini dapat kembali normal apabila terdapat rangsangan sensorik yang cukup. Secara umum, tidur ditandai dengan aktivitas fisik yang rendah, tingkat kesadaran yang berubah-ubah, perubahan dalam fungsi fisiologis tubuh, serta menurunnya respons terhadap rangsangan dari luar. Seseorang dapat dikatakan memiliki kualitas tidur yang baik apabila tidak mengalami kesulitan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, maupun menunjukkan gejala kurang tidur (Nurfantri dkk., 2022).

C. Manfaat Tidur

Erlin Ifadah dkk. (2024) menyebutkan tidur memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh seseorang. Beberapa manfaat tidur antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsentrasi, daya ingat dan mood



Gambar 1. 2 Konsentrasi dan daya ingat meningkat

Sumber: <https://www.merdeka.com/trending/8-cara-meningkatkan-konsentrasi-pada-anak-bantu-raih-prestasi-gemilang-kln.html>

2. Meningkatkan produksi hormon pertumbuhan tubuh. Tidur nyenyak (tidur non-REM tahap 3) merangsang terjadinya pelepasan hormone pertumbuhan (Human Growth Hormon) yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Hormone tersebut berkontribusi pada tumbuh kembang, perbaikan sel, meningkatkan massa otot pada anak-anak dan orang dewasa. Tidur yang nyenyak juga berpengaruh pada pelepasan hormone seks dan kesuburan



Gambar 1. 3 Meningkat Pertumbuhan

Sumber: <https://www.alodokter.com/peran-penting-hormon-pertumbuhan>

3. Memelihara fungsi jantung. (mencegah tekanan darah tinggi) Pada saat tidur terjadi penurunan atau melambatnya kinerja jantung, pembuluh darah dan system pernafasan karena berada pada tahap istirahat, semakin lambat, kondisi tersebut dapat meningkatkan kesehatan jantung



Gambar 1. 4 Memelihara fungsi jantung

Sumber: <https://hellosehat.com/jantung/anatomi-jantung/>

D. Fisiologi Tidur

Aktivitas tidur diatur oleh mekanisme kerja otak yang se-cara bergiliran mengaktivasi dan menekan pusat otak agar dapat tidur dan terjaga. Reticular activating system (RAS) merupakan bagian dari susuna saraf pusat yang juga merupakan sistem yang berfungsi mengatur kesiapsiagaan dan tidur. Pusat pengaturan tidur dan kesiapsiagaan terletak di mesensefalon serta area atas pons. Reticular Activating System (RAS) berperan dalam memberikan rangsangan berupa suara, penglihatan, sentuhan, dan rasa nyeri, serta dapat menerima stimulus dari korteks serebri yang berkaitan dengan emosi dan proses kognitif. Saat seseorang tertidur, diduga terjadi sekresi serotonin oleh sel-sel khusus yang berada di pons dan batang otak tengah, khususnya pada area yang dikenal sebagai bulbar synchronizing region (BSR). Sementara itu, kondisi terjaga bergantung pada rangsangan yang diterima oleh pusat otak dan sistem limbik. Selain itu, selama individu terjaga, sel-sel neuron di RAS akan menghasilkan zat katekolamin, seperti norepinefrin (Risnah dkk., 2022).

Secara umum, pola tidur manusia dikendalikan oleh jam biologis atau bioritme yang diatur oleh sistem RAS (Reticular Activating System) dan BSR (Bulbar Synchronizing Region), serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Salah satu bentuk bioritme yang paling dikenal adalah ritme sirkadian, yaitu siklus biologis yang berlangsung selama 24 jam. Ritme ini memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan fungsi tubuh, termasuk denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, sekresi hormon, proses metabolisme, serta performa fisik dan kondisi emosional seseorang. Irama sirkadian mengaki-batkan adanya pola tidur dan pola terjaga. Hal ini terjadi karena pola tersebut mengikuti jam biologis manusia di-mana

pada saat ritme fisiologis paling tinggi mengakibatkan kondisi terjaga dan pada saat ritme fisiologis terendah mengakibatkan kondisi tertidur (Risnawati dkk., 2022).

E. Tahapan Tidur

Risnawati dkk., (2022) menyebutkan tidur memiliki 2 tahapan yaitu REM dan NREM sebagai berikut:

1. Tidur gelombang lambat (NREM)

Tidur gelombang lambat, yang juga dikenal sebagai tidur dalam, istirahat total, atau lebih umum disebut tidur nyenyak, ditandai oleh aktivitas gelombang otak yang melambat dan tidak disertai mimpi. Tahapan ini disebut juga sebagai tidur delta, yang menunjukkan kondisi istirahat sepenuhnya, penurunan tekanan darah dan frekuensi pernapasan, lambatnya pergerakan bola mata, berkurangnya aktivitas bermimpi, serta menurunnya metabolisme tubuh. Berikut adalah tahapan dalam fase tidur non-rapid eye movement (NREM):

- a. Tahap I merupakan fase transisi dari kondisi sadar menuju tidur, ditandai dengan tubuh yang mulai rileks, kesadaran terhadap lingkungan masih ada, perasaan mengantuk, serta pergerakan bola mata ke kiri dan kanan. Denyut nadi dan laju pernapasan mulai melambat, dan individu masih mudah terbangun. Tahap ini berlangsung sekitar lima menit.
- b. Tahap II merupakan fase tidur ringan dengan aktivitas fisiologis yang semakin menurun. Ciri-cirinya meliputi gerakan mata yang menetap, penurunan detak jantung dan laju pernapasan, penurunan suhu tubuh dan metabolisme. Tahap ini berlangsung dalam durasi singkat, sekitar 10 hingga 15 menit.
- c. Tahap III merupakan fase tidur lebih dalam, ditandai dengan melambatnya denyut nadi, pernapasan, dan berbagai proses tubuh lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi sistem saraf parasimpatis. Pada tahap ini, individu menjadi lebih sulit untuk dibangunkan.
- d. Tahap IV merupakan fase tidur paling dalam dalam siklus NREM. Pada tahap ini, fungsi jantung dan sistem pernapasan berada pada tingkat minimal, pergerakan tubuh sangat sedikit, bola mata bergerak cepat, produksi asam lambung menurun, serta tonus otot berkurang. Individu pada tahap ini sangat sulit untuk dibangunkan.

2. Tidur paradoks (REM)

Tidur paradoks, yang dikenal juga sebagai tidur REM (Rapid Eye Movement), terjadi pada malam hari dengan durasi sekitar 5 hingga 20 menit dan umumnya muncul setiap 90 menit. Periode pertama dari fase ini biasanya dimulai setelah 80 hingga 100 menit dari waktu tidur. Namun, pada individu yang sangat kelelahan,

fase awal tidur berlangsung sangat cepat dan fase tidur paradoks dapat tidak terjadi sama sekali. Adapun ciri-ciri dari tidur paradoks meliputi:

- a. Biasanya disertai dengan mimpi yang aktif.
- b. Individu lebih sulit dibangunkan dibandingkan saat berada pada fase tidur nyenyak gelombang lambat.
- c. Tonus otot sangat rendah karena adanya inhibisi kuat terhadap proyeksi spinal oleh sistem pengaktivasi retikularis.
- d. Denyut jantung dan laju pernapasan menjadi tidak teratur.
- e. Terjadi gerakan otot perifer yang tidak terkoordinasi.
- f. Ditandai dengan pergerakan mata yang cepat, denyut nadi yang cepat dan tidak teratur, tekanan darah yang meningkat atau berfluktuasi, serta peningkatan sekresi lambung dan metabolisme tubuh.
- g. Fase tidur ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan mental, serta mendukung proses pembelajaran, memori, dan kemampuan adaptasi individu.



Gambar 1. 5 Tahapan Tidur

Sumber: [https://www-linked-in-com.translate.google/pulse/sleep-stages-quality-bmcmedical?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=imgs](https://www.linkedin-com.translate.google/pulse/sleep-stages-quality-bmcmedical?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=imgs)

F. Faktor yang Mempengaruhi tidur

Risnah dkk. (2022) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Penyakit

Perubahan kondisi tubuh dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Kondisi tubuh yang tidak sehat meningkatkan kebutuhan tidur. Misalnya seseorang yang mengalami penyakit infeksi membutuhkan lebih banyak tidur agar dapat menghemat energi tubuhnya. Kondisi sakit juga dapat menyebabkan pasien mengalami gangguan tidur.



Gambar 1. 6 Kondisi sakit yang dapat mempengaruhi tidur

Sumber: <https://umsb.ac.id/berita/index/1174-menemani-orang-yang-sakit>

2. Latihan dan kelelahan

Kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas fisik atau mental yang intens dapat meningkatkan kebutuhan tubuh akan tidur guna memulihkan energi yang telah digunakan. Individu yang mengalami kelelahan setelah beraktivitas cenderung lebih cepat tertidur. Dalam kondisi tersebut, durasi fase tidur gelombang lambat cenderung menjadi lebih singkat, sebagai respons adaptif tubuh untuk mempercepat proses pemulihan.



Gambar 1. 7 Kondisi latihan

Sumber: <https://juaraga.id/blogs/all/4-pilihan-latihan-angkat-beban-di-rumah-dan-cara-melakukannya-bagi-pemula>

3. Stress psikologis

Seseorang yang mengalami tekanan secara psikologis akan mengalami kegelisahan dan sulit untuk tertidur.



Gambar 1. 8 Kondisi stres

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/01/093000565/apa-penyebab-stres-dan-bagaimana-cara-menghindarinya-?page=all>

4. Obat

Obat juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses tidur, antara lain: jenis obat diuretik, an-tidepresan, golongan narkotik, beta blocker, dan kafein.



Gambar 1. 9 Konsumsi obat-obatan

Sumber: <https://www.halodoc.com/artikel/ini-daftar-dan-khasiat-obat-covid-19-yang-sudah-diizinkan-bpom>

5. Nutrisi

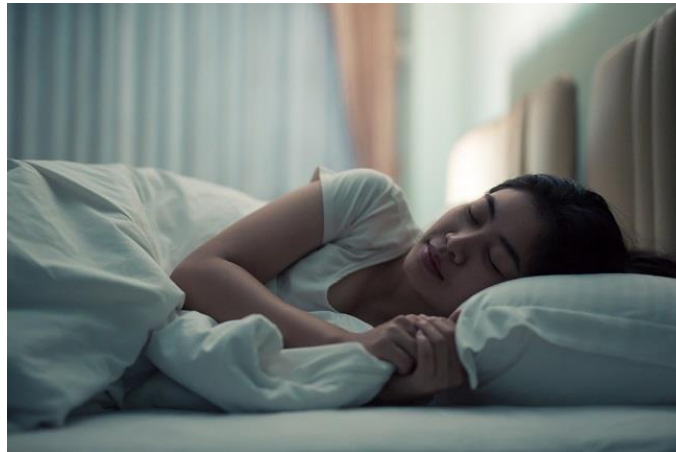
Nutrisi juga dapat mempengaruhi proses tidur dimana nutrisi yang adekuat dapat memudahkan individu cepat tertidur dan sebaliknya nutrisi yang tidak adekuat dapat mengakibatkan individu sulit tertidur. Salah satu contohnya adalah kandungan triptofan yang merupakan asam amino dalam protein yang dicerna dapat mempercepat terjadinya proses tidur.



Gambar 1. 10 Konsumsi makanan yang mempercepat maupun memperlambat tidur
Sumber: <https://health.kompas.com/read/23C11200100968/7-makanan-dan-minuman-untuk-bantu-agar-cepat-tidur-di-malam-hari>

6. Lingkungan

Lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap proses tidur, misalnya pencahayaan, tingkat kebisingan, suhu ruangan, posisi tempat tidur dan kebersihan dari tem-pat tidur tersebut.



Gambar 1. 11 Lingkungan yang nyaman untuk tidur

Sumber: <https://www.alodokter.com/kesulitan-tidur-coba-terapkan-sleep-hygiene>

7. Motivasi

Motivasi merupakan faktor internal berupa dorongan atau keinginan individu untuk tidur, yang berperan dalam memengaruhi kelancaran proses tidur. Sebaliknya, adanya keinginan atau usaha untuk menahan diri agar tetap terjaga dapat mengganggu mekanisme tidur dan berpotensi menyebabkan gangguan tidur.



Gambar 1. 12 Dorongan keinginan tidur

Sumber: https://troublesleeping-co-uk.translate.goog/what-is-sleep-drive/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=imgs

G. Dampak Kekurangan Tidur

Kekurangan tidur juga dapat menyebabkan bahaya jangka panjang. Hal ini meningkatkan risiko obesitas. Misalnya, sebuah penelitian terhadap remaja menunjukkan bahwa setiap jam tidur yang hilang, kemungkinan menjadi obesitas meningkat. Kekurangan tidur juga meningkatkan risiko obesitas pada kelompok usia lainnya. Tidur juga memengaruhi cara tubuh bereaksi terhadap insulin, hormon yang mengendalikan kadar glukosa (gula) darah. Kekurangan tidur mengakibatkan kadar gula darah lebih tinggi dari biasanya, yang dapat meningkatkan risiko diabetes. Kekurangan tidur yang berkelanjutan juga dapat mengubah cara sistem kekebalan tubuh dalam merespons. Misalnya, jika kekurangan tidur, seseorang mungkin kesulitan melawan infeksi umum. Selain itu, anak-anak dan remaja yang kekurangan tidur mungkin memiliki masalah bergaul dengan orang lain. Mereka mungkin merasa marah dan impulsif, mengalami perubahan suasana hati, merasa sedih atau tertekan, atau kurang motivasi. Mereka juga mungkin memiliki masalah dalam memperhatikan, dan mereka mungkin mendapat nilai lebih rendah dan merasa stres (K dan E, 2021) .

H. Lingkungan yang Nyaman

Manusia menilai kondisi lingkungan melalui rangsangan yang diterima oleh keenam inderanya, yang kemudian disalurkan melalui sistem saraf dan diolah oleh otak untuk dilakukan penilaian. Penilaian ini tidak hanya melibatkan aspek fisik dan biologis, tetapi juga aspek emosional. Berbagai rangsangan seperti suara, cahaya, bau, dan suhu diterima secara bersamaan dan diinterpretasikan oleh otak. Selanjutnya, otak memberikan evaluasi mengenai apakah kondisi tersebut nyaman atau tidak. Beberapa faktor yang memengaruhi kenyamanan lingkungan antara lain (Indriana dkk., 2023):

1. Pencahayaan ruang, yang harus memungkinkan penghuni melihat objek dengan jelas. Ketidakjelasan penglihatan dapat mengganggu aktivitas, sementara cahaya yang terlalu terang juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan visual.
2. Suhu udara, di mana produktivitas manusia mencapai puncaknya pada rentang temperatur sekitar 22–24 derajat Celsius.
3. Sirkulasi udara (ventilasi) yang baik, dengan kandungan oksigen sekitar 21%, karbon dioksida sebesar 0,03%, serta 0,9% campuran gas lainnya, sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan penghuni.
4. Bau, serta temperatur dan kelembaban yang dapat memengaruhi sensitivitas penciuman. Penggunaan pendingin udara (air conditioning) secara tepat dapat membantu menghilangkan bau yang mengganggu di lingkungan kerja.
5. Getaran mekanis, yaitu getaran yang berasal dari peralatan mekanis yang dapat merambat hingga ke tubuh dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

I. Strategy Keperawatan dalam Meciptakan Lingkungan Tidur yang Nyaman

Perawat dalam menangani permasalahan tidur pada klien, diperlukan tindakan pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk menciptakan suasana tidur yang nyaman sehingga kualitas tidur klien meningkat. Beberapa strategy yang dapat dilakukan perawat untuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman adalah sebagai berikut:

1. Sleep hygiene

Sleep hygiene merupakan suatu perilaku yang harus dilakukan sebelum tidur untuk membantu mendapatkan tidur yang optimal, baik dari segi kualitas maupun durasi tidur. Sleep hygiene yang harus dilakukan diantaranya adalah bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk pada akhir pekan, tidak menonton televisi di tempat tidur, menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur, menghindari tidur siang yang berkepanjangan dan menghindari olahraga yang berat sebelum tidur. Sleep hygiene dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya aspek gaya hidup dan perilaku serta faktor lingkungan seperti cahaya, kebisingan dan suhu. Sleep hygiene yang buruk dapat memberikan peluang terjadinya sulit tidur atau insomnia (Damanik dkk., 2022).



Gambar 1. 13 Sleep hygiene dalam meningkatkan lingkungan nyaman tidur
 Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/83598136830212950/>

2. Mengurangi paparan cahaya lampu

Cahaya yang terang mampu menembus kelopak mata dan merangsang aktivitas otak, sehingga menghambat kemampuan tubuh dan otak untuk beristirahat secara optimal. Paparan cahaya lampu terutama pada malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian dan menekan produksi hormon melatonin, yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur. Gangguan pada produksi melatonin ini dapat menurunkan kualitas tidur, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keseimbangan fisiologis maupun psikologis seseorang (Azri dkk., 2024).



Gambar 1. 14 mengurangi paparan lampu

Sumber: <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-3117284/lampu-kamar-jangan-bikin-silau-kalau-tak-ingin-kualitas-tidur-dikorbankan>

3. Terapi musik

Musik yang menenangkan dan menyenangkan sangat dibutuhkan dalam terapi musik untuk meningkatkan kualitas tidur. Terapi musik telah terbukti memberikan manfaat fisik dan psikologis, seperti menurunkan aktivitas saraf,

meningkatkan fungsi hormon, mengurangi aktivitas otak, serta memperkuat sistem imun. Melalui mekanisme tersebut, terapi musik mampu mengurangi kecemasan dan memberikan efek relaksasi, sehingga mendengarkan musik sebelum tidur dapat berpengaruh positif terhadap kualitas dan durasi tidur (Kamagi dan Sahar, 2021).

Salah satu jenis terapi musik yang umum digunakan untuk pasien dengan gangguan tidur adalah terapi white noise. Terapi ini bertujuan menciptakan kondisi internal yang mendukung proses tidur, terbukti efektif dalam merangsang tidur serta menstabilkan pikiran dan tubuh. White noise merupakan gabungan berbagai frekuensi suara yang menghasilkan suara dengungan atau desisan yang konsisten dan merata. Sifat ini membantu menutupi kebisingan sekitar yang berpotensi mengganggu tidur pasien. Selain itu, white noise memudahkan pasien untuk tertidur dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan tidur, sehingga kualitas tidur pasien membaik seiring waktu (Haryanti dkk., 2024) .



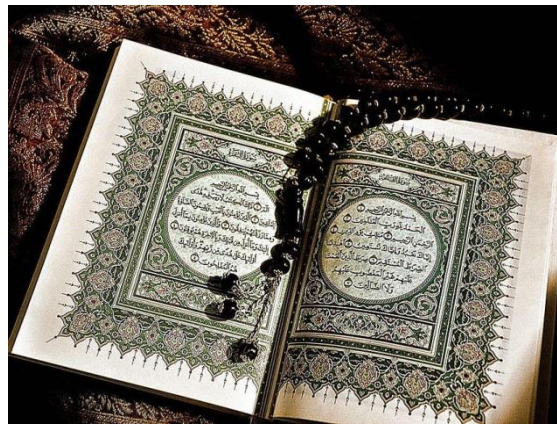
Gambar 1. 15 Terapi musik dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan tidur
Sumber: <https://www.alodokter.com/3-manfaat-terapi-musik-untuk-kesehatan-anda>

4. Terapi murottal Al-Qur'an

Terapi murottal adalah metode pengobatan yang menggunakan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dapat memberikan efek positif terhadap kondisi fisik dan psikologis seseorang. Murottal merupakan suara bacaan Al-Qur'an yang, ketika didengarkan, mampu menurunkan hormon stres, merangsang produksi endorfin alami, meningkatkan rasa rileks, mengurangi ketakutan, serta menurunkan tingkat nyeri, kecemasan, dan ketegangan. Selain itu, terapi ini juga dapat memperbaiki keseimbangan kimiawi dan hemodinamik tubuh dengan cara menurunkan tekanan darah, memperlambat pernapasan, denyut jantung, frekuensi nadi, dan aktivitas gelombang otak, sehingga menimbulkan perasaan nyaman secara menyeluruh (Astuti dkk., 2017).

Mendengarkan lantunan Al-Qur'an memberikan efek serupa dengan terapi musik santai dalam mekanisme patofisiologi rangsangan auditori. Sistem limbik

serebral, khususnya aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal dan kompleks amigdala, memediasi respons auditori melalui jalur pendengaran yang berkaitan dengan sirkuit emosi. Stimulus suara tersebut memicu reaksi psikofisiologis melalui pengaruhnya pada sistem limbik, yang dapat merangsang pelepasan hormon seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin pada sinapsis, yang pada akhirnya membantu mengurangi stres. Tempo lantunan murottal berkisar antara 60 hingga 120 denyut per menit (bpm), yang mampu menyelaraskan detak jantung dengan ritme suara tersebut. Ritme yang lambat ini sesuai dengan irama detak jantung manusia. Mendengarkan murottal Al-Qur'an sekali saja dapat menghasilkan gelombang delta, yang menandakan kondisi relaksasi yang mendalam (Khayati dkk., 2021).



Gambar 1. 16 Terapi murottal dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan tidur
Sumber: <https://www.pxfuel.com/id/desktop-wallpaper-fxqz>

5. Terapi dzikir

Terapi terapi zikir dapat menyebabkan otak bekerja. Saat otak menerima sebuah rangsangan yang berasal dari luar, maka otak akan menghasilkan neurotransmitter, yaitu neuropeptide atau hormone beta endorfin. Selesaiannya otak menghasilkan zat tersebut, maka zat ini akan mengalir dan melekat dengan reseptornya pada otak dan diserap di dalam tubuh yang lalu akan memberi pengaruh kembali berupa kenikmatan dan kenyamanan. Rasa nyaman itu dapat membantu mengurangi gangguan insomnia yang merupakan kondisi tidur yang tidak baik secara kuantitas dan kualitas (Clarysia dkk., 2024).



Gambar 1. 17 Terapi dzikir dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan tidur
Sumber: <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2022/07/26/122937/6-manfaat-terapi-dzikir-dalam-mengelola-emosi>

Selain beberapa strategi diatas, Standart Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) juga memiliki beberapa strategi dalam mengatur lingkungan tidur yang nyaman bagi klien. Beberapa strategi intervensi yang terdapat dalam SIKI adalah sebagai berikut (SIKI, 2018):

a. Dukungan tidur

1) Observasi

- a) Identifikasi pola aktivitas dan tidur
- b) Identifikasi faktor pengganggu tidur (fisik atau psikologis)
- c) Identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur (mis. kopi, teh, alkohol, makan mendekati waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur)
- d) Identifikasi obat tidur yang dikonsumsi

2) Terapeutik

- a) Modifikasi lingkungan (mis. pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur)
- b) Batas waktu tidur siang, jika perlu
- c) Fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur
- d) Tetapkan jadwal tidur rutin
- e) Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan (mis. pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur)
- f) Sesuaikan jadwal pemberian obat atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga

3) Edukasi

- a) Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit
- b) Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur
- c) Anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur

- d) Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM
- e) Ajarkan faktor-faktor berkontribusi terhadap gangguan pola tidur (mis. psikologis, gaya hidup, sering berubah shift bekerja)
- f) Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara nonfarmakologi lainnya
- b. Manajemen lingkungan
 - 1) Observasi
 - a) Identifikasi keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - 2) Terapeutik
 - a) Atur suhu lingkungan yang sesuai
 - b) Sediakan ruang berjalan yang cukup dan aman
 - c) Sediakan tempat tidur dan lingkungan yang bersih dan nyaman
 - d) Sediakan pewangi ruangan, Jika perlu
 - e) Hindari pandangan langsung ke kamar mandi, toilet, atau peralatan untuk eliminasi
 - f) Hindari paparan langsung dengan cahaya matahari dan cahaya yang tidak perlu
 - g) Izinkan membawa benda-benda yang disukai dari rumah
 - 3) Edukasi
 - a) Jelaskan cara membuat lingkungan rumah yang aman
- c. Terapi musik
 - 1) Observasi
 - a) Identifikasi perubahan perilaku atau fisiologis yang akan dicapai (mis. relaksasi, stimulasi, konsentrasi, pengurangan rasa sakit)
 - b) Identifikasi minat terhadap musik
 - c) Identifikasi musik yang disukai
 - 2) Terapeutik
 - a) Pilih musik yang disukai
 - b) Posisikan dalam posisi yang nyaman
 - c) Batasi rangsangan eksternal selama terapi dilakukan (mis. lampu, suara, pengunjung, panggilan telepon)
 - d) Sediakan peralatan terapi musik
 - e) Atur volume suara yang sesuai
 - f) Berikan terapi musik sesuai indikasi
 - g) Hindari pemberian terapi musik dalam waktu yang lama
 - h) Hindari pemberian terapi musik saat cedera kepala akut
 - 3) Edukasi
 - a) Jelaskan tujuan dan prosedur terapi musik

- b) Anjurkan rileks selama mendengarkan musik

J. Penutup

Tidur merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan fisik, emosional, dan mental seseorang. Kualitas tidur dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan, status kesehatan, serta aspek psikologis dan spiritual. Dalam konteks keperawatan, perawat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan tidur yang nyaman bagi pasien dengan menerapkan strategi seperti sleep hygiene, pengurangan cahaya berlebih, serta terapi musik, murottal Al-Qur'an, dan dzikir. Penerapan strategi-strategi ini secara holistik dapat membantu meningkatkan kualitas tidur pasien, mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, intervensi keperawatan yang tepat dalam menciptakan lingkungan tidur yang nyaman merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan yang berkualitas.

Referensi

- Astuti, A., N. Nursalam, dan L. Hidayati. 2017. The comfort of post orthopedic surgery's client given murottal al-qur'an. Atlantis Press. 3(Inc):71–74.
- Azri, S. M., A. T. E. Sinaga, S. Nurhadijah, dan Desni Theresia Butar-butur. 2024. PERBEDAAN kualitas tidur mahasiswa program studi ilmu keperawatan antara kondisi lampu mati dengan kondisi lampu hidup. *Journal of Nursing Science Research*. 1:56–66.
- Clarysia, N. D., N. Mubarakah, I. Nurulisa, Fakhurroihaan, dan A. D. Pratama. 2024. Penurunan tingkat insomnia ringan melalui terapi zikir pada mahasiswa. *Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences*. 1(4):161–170.
- Damanik, C., Z. Fauza, dan A. Achmad. 2022. Hubungan antara pelaksanaan sleep hygiene dengan kualitas tidur pada karyawan di lingkungan itkes wiyata husada samarinda. *Jurnal Keperawatan Wiyata*. 3(1):68.
- Devi, N. K. A. dan M. Heri. 2021. Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur pada anak: literature review. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*. 4(1):7–16.
- Erlin Ifadah, F. H. Wada, Masroni, Y. L. Tinungki, S. Aminah, R. Afrina, S. Amir, W. Pramadhani, M. I. S. Hasiolan, W. T. Ningsih, R. Nugraha, dan Y. A. Nuryan. 2024. BUKU AJAR KEPERAWATAN DASAR. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Grandner, M. A., D. Y. Valencia, A. A. Seixas, K. Olivier, R. A. Gallagher, W. D. S. Killgore, L. Hale, C. Branas, dan P. Alfonso-Miller. 2022. Development and initial validation of the assessment of sleep environment (ase): describing and quantifying the impact of subjective environmental factors on sleep. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 19(20):1–17.
- Haryanti, N., R. N. Agung, N. Yunitri, F. Rayasari, dan C. I. Sulistyorini. 2024. Penerapan evidence based practice therapy music white noise terhadap gangguan tidur pada pasien stroke. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*. 4(4):1320–1333.
- Indriana, D., R. Yunita, S. Tinggi, I. Kesehatan, H. Pesantren, dan Z. Hasan. 2023. Kualitas tidur pasien di ruang rawat inap kelas 3. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*. 2(6):178–185.
- K, E. dan C. E. 2021. *Nursing Fundamentals*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK591812/>
- Kamagi, R. H. dan J. Sahar. 2021. TERAPI musik pada gangguan tidur insomnia. *Journal of Telenursing (JOTING)*. 75(17):399–405.
- Karna, B., A. Sankari, dan G. Tatikonda. 2023. *Sleep Disorder*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560720/>
- Khayati, C. D. N., P. Adriani, dan S. Khasanah. 2021. PENGARUH terapi murotal terhadap

- kualitas tidur pada lansia. *Jurnal of Nurisng and Health*. 2(2):827–832.
- Nuramalia, L. dan K. Kuntarti. 2017. Pengetahuan dan motivasi perawat berperan penting dalam mengatasi masalah tidur di rumah sakit. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 20(3):176–184.
- Nurfantri, Ernawati, Ahmadi, A. M. P. Pelawi, F. M. Simanjuntak, R. L. Siantar, E. A. Mawardi, R. Siregar, T. R. Aritonang, N. C. Nurvitriana, Y. Widjayanti, K. Deniati, H. Nisa, E. Meliyana, dan L. Indrawati. 2022. *Keperawatan Dasar*. Malang: Rena Cipta Mandiri.
- Risnah, Musdalifah, A. A. Amal, Nurhidayah, dan Rasmawati. 2022. *Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Berdasarkan Referensi SDKI, SLKI Dan SIKI*. Jakarta Timur: CV. TRANS INFO MEDIA. 1.
- SAFRUDIN, S., R. ROSIDAWATI, dan A. AZIZ. 2023. Faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan tidur pada ibu post partum hari pertama sampai hari ketiga di puskesmas kelurahan aren jaya bekasi timur tahun 2020. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)*. 1(3):203–212.
- SIKI. 2018. *Standart Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi Dan Tindakan Keperawatan*. Edisi 1. Jakarta selatan: DPP PPNI.
- Widiyati, S., B. W. F. Anandi, dan S. Supriyadi. 2023. Hubungan tingkat kecemasan terhadap kualitas tidur pada klien kesadaran composmentis di ruang icu. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. 13(3):909–916.

BAB II

EDUKASI PASIEN TENTANG KEBIASAAN TIDUR SEHAT

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Edukasi Tidur Sehat dalam Manajemen Gangguan Tidur

Gangguan tidur menjadi salah satu tantangan kesehatan yang signifikan dalam kehidupan modern, dengan dampak luas yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, hingga produktivitas individu. Salah satu pendekatan penting dalam mengatasi gangguan tidur adalah melalui edukasi tidur sehat atau yang dikenal dengan istilah *sleep hygiene*. Edukasi tidur sehat meliputi pemberian informasi dan panduan kepada pasien terkait kebiasaan tidur yang baik dan sehat, pengaturan lingkungan tidur yang kondusif, serta modifikasi gaya hidup yang mendukung kualitas tidur yang optimal (Irish et al., 2021).

Intervensi edukasi tidur sehat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pasien dan mengurangi berbagai gejala gangguan tidur seperti insomnia, apnea tidur, serta gangguan siklus tidur-bangun lainnya (Matsuda & Yoshida, 2022). Sebuah meta-analisis terbaru menegaskan bahwa edukasi tidur sehat yang diberikan secara sistematis mampu secara signifikan menurunkan tingkat keparahan insomnia dan meningkatkan efisiensi tidur (Chung, Lee, & Yeung, 2023). Oleh karena itu, edukasi tidur sehat tidak hanya menjadi komponen tambahan dalam manajemen gangguan tidur, namun sudah menjadi elemen inti dalam praktik keperawatan berbasis bukti.

Strategi edukasi tidur sehat juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, yang selanjutnya mendukung proses pemulihan serta memperkuat interaksi terapeutik antara pasien dengan tenaga kesehatan. Dengan meningkatnya pengetahuan pasien tentang pentingnya tidur sehat, diharapkan pasien dapat lebih aktif dalam mengelola pola tidur mereka sendiri, sehingga tercipta pendekatan manajemen tidur yang bersifat mandiri, efektif, dan berkelanjutan (Silva, Martinez, & Loreda, 2022).

2. Prevalensi dan Dampak Gangguan Tidur pada Kualitas Hidup Pasien

Gangguan tidur merupakan fenomena global dengan prevalensi yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 30% hingga 50% populasi dunia mengalami berbagai jenis gangguan tidur, termasuk insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome (RLS),

serta gangguan tidur terkait gangguan mental seperti depresi dan kecemasan (World Health Organization [WHO], 2021). Di Indonesia sendiri, data terbaru menunjukkan prevalensi gangguan tidur mencapai angka 28–35%, terutama didominasi oleh insomnia kronis yang dialami oleh kalangan usia dewasa produktif hingga lansia (Permana, Oriza, & Fatimah, 2022).

Dampak gangguan tidur terhadap kualitas hidup pasien sangat signifikan dan kompleks. Gangguan tidur tidak hanya menurunkan kualitas tidur itu sendiri, tetapi juga mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif seperti gangguan kognitif, penurunan daya ingat, serta kesulitan konsentrasi. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperburuk gejala gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, hingga meningkatkan risiko gangguan metabolisme seperti obesitas, diabetes melitus tipe 2, hipertensi, serta penyakit kardiovaskular lainnya (Talwar, Sen, & Singh, 2020).

Kualitas hidup pasien dengan gangguan tidur sering kali mengalami penurunan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya kelelahan kronis, penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan interpersonal, hingga gangguan pada fungsi sosial secara umum (Peters, Calvo, & Ryan, 2021). Gangguan tidur yang tidak tertangani dengan baik juga diketahui meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan lalu lintas, sehingga berpotensi menyebabkan dampak yang lebih serius baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (WHO, 2021).

Dengan tingginya prevalensi serta dampak negatif yang luas tersebut, pengelolaan gangguan tidur melalui pendekatan edukasi tidur sehat menjadi sangat penting untuk mengurangi beban kesehatan masyarakat secara umum serta memperbaiki kualitas hidup pasien secara khusus. Edukasi tidur sehat sebagai strategi preventif dan promotif yang tepat dapat membantu pasien memahami pentingnya tidur berkualitas, serta mendukung mereka dalam menerapkan kebiasaan tidur sehat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

B. Konsep dan Prinsip Dasar Kebiasaan Tidur Sehat (Sleep Hygiene)

1. Definisi dan Komponen Utama Kebiasaan Tidur Sehat

Kebiasaan tidur sehat, atau dikenal dengan istilah *sleep hygiene*, didefinisikan sebagai kumpulan perilaku dan praktik yang secara konsisten mendukung kualitas tidur optimal serta menjaga kesehatan tidur secara umum (Irish et al., 2021). Kebiasaan tidur sehat tidak hanya bertujuan meningkatkan kuantitas tidur, tetapi juga kualitas tidur, yang mencakup efisiensi tidur, kedalaman tidur, dan rasa segar ketika bangun.

Menurut Matsuda dan Yoshida (2022), kebiasaan tidur sehat terdiri atas beberapa komponen utama, di antaranya adalah:

- a. Menetapkan jadwal tidur dan bangun yang teratur.
- b. Menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, seperti kamar tidur yang nyaman, suhu ruangan yang sejuk, minim gangguan cahaya maupun suara.
- c. Menghindari konsumsi kafein, alkohol, nikotin, atau zat stimulan lainnya menjelang waktu tidur.
- d. Melakukan aktivitas relaksasi menjelang tidur, seperti meditasi, latihan pernapasan, atau peregangan ringan.
- e. Mengurangi paparan layar elektronik sebelum tidur, seperti smartphone, tablet, atau televisi.
- f. Menghindari aktivitas yang tidak terkait tidur (misalnya bekerja atau makan) di tempat tidur, agar tubuh terbiasa mengasosiasikan tempat tidur dengan tidur.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi mengenai kebiasaan tidur sehat mampu menurunkan prevalensi gangguan tidur, seperti insomnia, serta meningkatkan efisiensi tidur secara signifikan pada populasi dewasa maupun lansia (Irish et al., 2021; Silva, Martinez, & Loreda, 2022).

2. Prinsip Dasar Regulasi Siklus Tidur-Bangun (Circadian Rhythm)

Siklus tidur-bangun, atau dikenal sebagai *circadian rhythm*, adalah ritme biologis alami yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan terjaga selama periode 24 jam. Siklus ini dikendalikan oleh sebuah pusat di otak yang disebut inti suprachiasmaticus (SCN), terletak di hipotalamus anterior, yang sensitif terhadap paparan cahaya dan gelap lingkungan eksternal (Potter, Perry, Stockert, & Hall, 2021).

Prinsip dasar regulasi siklus tidur-bangun melibatkan interaksi antara faktor lingkungan, hormonal, dan neurologis. Saat lingkungan menjadi gelap, SCN mengirimkan sinyal ke kelenjar pineal untuk meningkatkan produksi hormon melatonin, yang bertanggung jawab untuk menimbulkan rasa kantuk dan membantu memulai tidur (Xie et al., 2021). Sebaliknya, ketika terkena paparan cahaya, produksi melatonin ditekan, yang menyebabkan tubuh tetap terjaga.

Disregulasi siklus tidur-bangun ini sering dikaitkan dengan berbagai gangguan tidur, seperti insomnia, jet lag, gangguan tidur akibat shift kerja, dan gangguan tidur fase tertunda (*Delayed Sleep Phase Disorder*) (Chung, Lee, & Yeung, 2023). Oleh karena itu, memahami prinsip ini sangat penting dalam implementasi edukasi kebiasaan tidur sehat.

3. Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Kualitas Tidur Pasien

Kualitas tidur dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi aspek biologis, psikologis, dan medis. Faktor biologis mencakup usia, jenis kelamin, serta kondisi genetik. Penelitian menunjukkan bahwa lansia lebih rentan terhadap gangguan tidur karena perubahan fisiologis yang berkaitan dengan penuaan, seperti berkurangnya durasi tidur tahap dalam (tidur non-REM) (Xie et al., 2021).

Faktor psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, serta gangguan mood lainnya, juga berkontribusi terhadap gangguan tidur, khususnya insomnia. Sebuah studi sistematis menunjukkan bahwa individu yang mengalami gangguan kecemasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan tidur kronis (Kim et al., 2020).

Faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas tidur meliputi lingkungan fisik, kebiasaan perilaku, gaya hidup, serta intervensi medis. Lingkungannya meliputi kebisingan, cahaya terang di malam hari, suhu ruangan yang terlalu panas atau dingin, serta kualitas tempat tidur (Peters, Calvo, & Ryan, 2021). Selain itu, perilaku sehari-hari seperti konsumsi kafein, alkohol, pola makan, serta penggunaan gawai menjelang tidur terbukti memengaruhi durasi dan kualitas tidur seseorang secara signifikan (Toma & Wu, 2023).

Identifikasi dan pemahaman tentang faktor internal dan eksternal ini penting dalam merancang intervensi keperawatan yang efektif untuk memperbaiki kualitas tidur pasien. Edukasi yang menyoroti perubahan perilaku dan lingkungan pasien akan secara nyata berdampak positif terhadap perbaikan tidur serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

C. Identifikasi Kebutuhan Edukasi Pasien

1. Penilaian Awal Pola Tidur Pasien dan Gaya Hidup

Penilaian awal pola tidur dan gaya hidup pasien merupakan langkah fundamental dalam menentukan kebutuhan edukasi mengenai kebiasaan tidur sehat. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait pola tidur, gangguan yang dialami, serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Menurut studi oleh Irish et al. (2021), penilaian ini meliputi riwayat tidur pasien, durasi tidur, kualitas tidur yang dirasakan, waktu tidur dan bangun rutin, serta kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur. Asesmen tersebut juga mencakup gaya hidup pasien seperti konsumsi kafein, nikotin, alkohol, tingkat aktivitas fisik, kebiasaan penggunaan gawai menjelang tidur, serta kondisi emosional seperti stres dan kecemasan.

Penelitian menunjukkan bahwa penilaian pola tidur yang akurat mampu mengidentifikasi penyebab potensial gangguan tidur secara lebih spesifik, yang

selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam merancang intervensi edukasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu (Matsuda & Yoshida, 2022).

2. Instrumen dan Metode Asesmen Kebutuhan Edukasi Pasien tentang Tidur Sehat

Dalam praktik keperawatan, berbagai instrumen dan metode asesmen telah dikembangkan untuk mengevaluasi kebutuhan edukasi pasien terkait kebiasaan tidur sehat. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Menurut studi terbaru, PSQI efektif untuk mengukur kualitas tidur pasien secara komprehensif, termasuk durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, serta penggunaan obat tidur (Buysse et al., 2021).

Instrumen lain yang umum digunakan dalam asesmen kebutuhan edukasi tidur sehat adalah Epworth Sleepiness Scale (ESS), yang digunakan untuk mengukur tingkat kantuk pasien di siang hari sebagai indikator kualitas tidur malam sebelumnya (Johns, 2021). Selain penggunaan instrumen standar, wawancara mendalam dan observasi langsung juga sering dilakukan sebagai metode asesmen kualitatif untuk melengkapi data kuantitatif. Pendekatan kombinasi instrumen kuantitatif dan wawancara mendalam memberikan gambaran lebih holistik tentang kebutuhan pasien dalam edukasi kebiasaan tidur sehat (Silva, Martinez, & Loreda, 2022).

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan perangkat digital seperti smartwatch dan aplikasi pelacakan tidur (sleep-tracking apps) juga semakin populer dan terbukti dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi kebutuhan edukasi tidur sehat secara akurat melalui data objektif yang diperoleh dari perangkat tersebut (Peters, Calvo, & Ryan, 2021).

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pasien terhadap Edukasi Tidur Sehat

Kepatuhan pasien terhadap edukasi tidur sehat merupakan faktor penting dalam keberhasilan manajemen gangguan tidur. Namun, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pasien terhadap edukasi tidur sehat, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal mencakup tingkat pengetahuan pasien tentang pentingnya tidur sehat, motivasi untuk berubah, persepsi terhadap keparahan gangguan tidur, serta kemampuan pasien dalam mengelola kebiasaan tidur secara mandiri (Toma & Wu, 2023). Sebuah studi yang dilakukan Chung, Lee, & Yeung (2023) menunjukkan bahwa pasien dengan tingkat motivasi dan pemahaman yang tinggi terhadap pentingnya tidur sehat cenderung lebih patuh menjalankan rekomendasi dibandingkan pasien dengan pemahaman yang rendah.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi dukungan sosial, lingkungan fisik yang mendukung tidur, serta pendekatan edukasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Penelitian mengindikasikan bahwa dukungan dari keluarga dan orang terdekat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menerapkan kebiasaan tidur sehat. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif, seperti kebisingan atau ketidaknyamanan tempat tidur, dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan perilaku tidur sehat (Silva et al., 2022; Irish et al., 2021).

Selain itu, faktor-faktor terkait tenaga kesehatan seperti gaya komunikasi, keterampilan edukasi, serta metode penyampaian informasi juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pasien. Pasien yang menerima edukasi melalui metode yang interaktif dan personalisasi, seperti diskusi kelompok kecil, konseling tatap muka, atau aplikasi digital interaktif, terbukti lebih patuh dibandingkan pasien yang menerima edukasi dalam bentuk informasi umum seperti brosur atau poster semata (Peters et al., 2021).

Oleh karena itu, penting bagi tenaga keperawatan untuk mengidentifikasi secara dini faktor-faktor tersebut dalam proses asesmen awal agar edukasi yang diberikan lebih efektif, tepat sasaran, serta berdampak jangka panjang pada kualitas tidur pasien.

D. Strategi Edukasi Efektif dalam Mengajarkan Kebiasaan Tidur Sehat

1. Metode Komunikasi Terapeutik yang Efektif untuk Edukasi Pasien Gangguan Tidur

Komunikasi terapeutik adalah interaksi yang dirancang secara sengaja oleh tenaga kesehatan untuk mendorong proses penyembuhan dan perubahan perilaku pasien. Dalam konteks gangguan tidur, metode komunikasi terapeutik menjadi kunci dalam menyampaikan edukasi kebiasaan tidur sehat agar pasien lebih reseptif dan termotivasi untuk mengubah perilakunya. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pendekatan komunikasi terapeutik seperti wawancara motivasional (*motivational interviewing*) efektif meningkatkan motivasi pasien dalam mengubah kebiasaan tidur yang tidak sehat (Bakken, et al., 2021).

Metode wawancara motivasional menekankan pendekatan empati, eksplorasi hambatan internal pasien, serta membangun kepercayaan diri pasien dalam mengubah perilaku. Selain itu, pendekatan komunikasi asertif, di mana tenaga kesehatan memberikan informasi dengan jelas dan lugas namun tetap menghormati pasien, juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai pentingnya kebiasaan tidur sehat (Richards et al., 2021).

Penerapan komunikasi terapeutik secara efektif membutuhkan keterampilan interpersonal yang tinggi, empati, dan kemampuan aktif

mendengarkan. Menurut Lee et al. (2022), komunikasi terapeutik yang efektif secara signifikan berhubungan dengan meningkatnya kepatuhan pasien terhadap edukasi tidur sehat, khususnya pada pasien dengan insomnia kronis.

2. Media Edukasi yang Terbukti Efektif dalam Meningkatkan Pemahaman Pasien

Pemilihan media edukasi yang tepat merupakan faktor penting dalam keberhasilan edukasi tidur sehat. Berbagai media telah terbukti efektif meningkatkan pemahaman pasien tentang tidur sehat, antara lain: e-learning, video edukasi, booklet edukasi, dan aplikasi seluler (*mobile apps*).

Penelitian yang dilakukan oleh Peters, Calvo, dan Ryan (2021) menunjukkan bahwa media edukasi berbasis digital seperti e-learning dan mobile apps memberikan hasil positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan pasien dan perubahan perilaku tidur mereka. Keuntungan utama media digital adalah kemudahan akses, interaktivitas tinggi, serta kemampuan menyesuaikan konten secara personal berdasarkan kebutuhan pasien.

Studi lain oleh Toma dan Wu (2023) menemukan bahwa penggunaan aplikasi seluler khusus yang menyediakan fitur seperti pelacakan tidur, pengingat perilaku tidur sehat, serta modul edukasi interaktif, secara signifikan meningkatkan kebiasaan tidur sehat dan kualitas tidur pasien dibandingkan metode edukasi konvensional seperti booklet cetak. Video edukasi yang menampilkan demonstrasi teknik relaksasi dan pengaturan lingkungan tidur yang nyaman juga efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien karena informasi visual yang jelas dan mudah dipahami (Kim et al., 2020).

Booklet edukasi tetap menjadi pilihan efektif dalam situasi di mana akses digital terbatas. Menurut penelitian terbaru, booklet dengan desain sederhana, ilustrasi menarik, dan bahasa yang jelas serta mudah dipahami secara signifikan membantu meningkatkan pemahaman pasien tentang kebiasaan tidur sehat, khususnya pada kelompok pasien lansia (Irish et al., 2021).

3. Peran Keluarga dan Caregiver dalam Mendukung Perubahan Kebiasaan Tidur Sehat Pasien

Peran keluarga dan caregiver dalam mendukung perubahan kebiasaan tidur sehat merupakan elemen penting dalam edukasi pasien. Dukungan keluarga telah terbukti secara positif berhubungan dengan tingkat kepatuhan pasien dalam menjalankan kebiasaan tidur yang sehat dan berkelanjutan (Lau et al., 2021).

Menurut sebuah studi terbaru oleh Chung, Lee, dan Yeung (2023), keterlibatan keluarga dalam proses edukasi mampu memberikan motivasi

emosional yang kuat bagi pasien. Keluarga berperan sebagai sumber dukungan sosial, yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri pasien untuk menerapkan perubahan perilaku tidur secara konsisten. Dalam konteks ini, keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, mengingatkan pasien untuk mengikuti jadwal tidur, serta mengurangi kebisingan atau gangguan yang dapat memengaruhi kualitas tidur.

Penelitian oleh Silva et al. (2022) juga menegaskan bahwa caregiver memiliki peran penting dalam mendukung pasien, khususnya pada pasien dengan kondisi medis kompleks atau lansia yang memiliki keterbatasan fisik dan kognitif. Caregiver dapat membantu pasien dalam mempraktikkan teknik relaksasi, mengelola stres, serta memastikan penerapan jadwal tidur secara teratur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas edukasi tidur sehat.

Oleh karena itu, edukasi tidur sehat harus dirancang dengan melibatkan keluarga atau caregiver sebagai bagian integral dari strategi edukasi, sehingga perubahan perilaku tidur pasien dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

E. Intervensi Berbasis Bukti dalam Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat

1. Efektivitas Terapi Perilaku Kognitif (CBT-I) dalam Mengubah Kebiasaan Tidur Pasien

Terapi Perilaku Kognitif untuk Insomnia (*Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia* atau CBT-I) merupakan pendekatan psikologis yang dirancang secara khusus untuk mengatasi gangguan tidur dengan cara mengubah pola pikir (kognitif) dan perilaku pasien yang terkait tidur. CBT-I mencakup beberapa komponen penting, di antaranya restriksi tidur, kontrol stimulus, teknik relaksasi, edukasi tidur sehat, serta restrukturisasi kognitif (Chung, Lee, & Yeung, 2023).

Bukti terkini menunjukkan bahwa CBT-I sangat efektif dalam mengatasi insomnia kronis, dengan manfaat jangka panjang yang lebih baik dibandingkan terapi farmakologi. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Irish et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien yang menjalani CBT-I mengalami perbaikan yang signifikan dalam durasi tidur, efisiensi tidur, dan penurunan gejala kecemasan serta depresi. Efektivitas CBT-I didukung oleh kemampuan terapi ini dalam meningkatkan kesadaran pasien terhadap faktor-faktor yang memperburuk insomnia, sehingga mereka mampu menerapkan kebiasaan tidur yang lebih sehat secara konsisten.

CBT-I juga terbukti efektif dalam berbagai kelompok usia dan populasi khusus seperti lansia, pasien dengan penyakit kronis, dan pekerja shift malam (Richards et al., 2021). Keunggulan CBT-I sebagai intervensi berbasis bukti yang

aman dan minim efek samping menjadikannya pilihan utama dalam edukasi kebiasaan tidur sehat.

2. Edukasi Mengenai Praktik Relaksasi dan Teknik Manajemen Stres untuk Tidur yang Lebih Baik

Teknik relaksasi dan manajemen stres adalah pendekatan nonfarmakologi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur. Teknik ini bertujuan mengurangi aktivasi fisiologis dan psikologis yang menghambat tidur, dengan membantu pasien mencapai kondisi rileks sebelum tidur. Beberapa teknik relaksasi yang umum diterapkan dalam edukasi tidur sehat antara lain pernapasan dalam (*deep breathing*), relaksasi otot progresif, meditasi, dan visualisasi (Kim et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2021) menemukan bahwa teknik relaksasi otot progresif efektif menurunkan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur pasien dengan gangguan tidur kronis. Demikian pula, meditasi dan latihan pernapasan dalam secara konsisten dilaporkan mampu menurunkan tingkat stres, yang berkontribusi pada perbaikan signifikan dalam pola tidur, khususnya pada pasien dengan gangguan tidur yang disertai stres tinggi atau gangguan kecemasan (Liu et al., 2020).

Edukasi pasien tentang teknik-teknik ini membantu mereka memiliki keterampilan manajemen stres mandiri, sehingga mampu menciptakan rutinitas tidur yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Implementasi Terapi Komplementer dan Alternatif Berbasis Bukti (Aromaterapi, Yoga, Mindfulness) dalam Memperbaiki Kebiasaan Tidur Pasien

Dalam beberapa tahun terakhir, terapi komplementer dan alternatif seperti aromaterapi, yoga, dan mindfulness telah menjadi intervensi tambahan populer dalam memperbaiki kualitas tidur pasien.

Aromaterapi merupakan terapi yang menggunakan minyak esensial seperti lavender dan chamomile untuk meredakan kecemasan, menurunkan stres, serta memperbaiki pola tidur pasien. Studi terbaru menunjukkan bahwa aromaterapi lavender efektif dalam meningkatkan kualitas tidur, terutama pada populasi lansia dan pasien yang mengalami gangguan tidur karena stres dan kecemasan (Karadag et al., 2021).

Yoga juga terbukti efektif dalam memperbaiki kebiasaan tidur dengan cara meningkatkan relaksasi fisik dan mental. Sebuah tinjauan sistematis menunjukkan bahwa intervensi yoga teratur mampu secara signifikan memperpanjang durasi tidur, mengurangi latensi tidur, serta meningkatkan kepuasan terhadap tidur

pada individu yang mengalami gangguan tidur ringan hingga sedang (Wang et al., 2020).

Sementara itu, intervensi berbasis mindfulness berfokus pada peningkatan kesadaran pasien terhadap kondisi fisik dan mental secara sadar serta tanpa penilaian. Penelitian terbaru menemukan bahwa mindfulness-based stress reduction (MBSR) secara efektif meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan gejala insomnia pada pasien dengan gangguan tidur kronis (Talwar, Sen, & Singh, 2020).

Implementasi terapi komplementer ini dalam edukasi pasien tidak hanya memberikan manfaat langsung terhadap kualitas tidur, tetapi juga membantu pasien membangun kebiasaan tidur sehat jangka panjang melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek fisik, emosional, dan psikologis.

F. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat

1. Parameter Klinis dan Non-Klinis untuk Mengevaluasi Efektivitas Edukasi

Evaluasi keberhasilan edukasi tidur sehat merupakan tahap penting dalam manajemen pasien dengan gangguan tidur. Parameter evaluasi meliputi parameter klinis dan non-klinis. Parameter klinis yang sering digunakan mencakup kualitas tidur (dengan instrumen seperti Pittsburgh Sleep Quality Index/PSQI), durasi tidur, latensi tidur (waktu yang dibutuhkan untuk tertidur), efisiensi tidur (persentase waktu tidur dibandingkan total waktu di tempat tidur), serta frekuensi terbangun saat tidur (Buysse et al., 2021).

Parameter klinis lainnya yang relevan adalah perubahan gejala insomnia, penurunan rasa kantuk di siang hari yang diukur melalui Epworth Sleepiness Scale (ESS), serta penurunan tingkat keparahan gejala kecemasan dan depresi yang sering menyertai gangguan tidur (Johns, 2021; Irish et al., 2021).

Selain parameter klinis, evaluasi efektivitas edukasi juga mencakup parameter non-klinis seperti perubahan pengetahuan pasien tentang kebiasaan tidur sehat, kepatuhan pasien dalam menerapkan rekomendasi edukasi, persepsi pasien terhadap kualitas hidup, serta tingkat kepuasan pasien terhadap edukasi yang diterima (Matsuda & Yoshida, 2022). Parameter non-klinis ini penting karena mencerminkan dampak edukasi tidur sehat terhadap aspek psikososial pasien yang menunjang keberhasilan jangka panjang dalam perubahan perilaku tidur.

2. Indikator Keberhasilan Intervensi Edukasi Berdasarkan Penelitian Terkini

Indikator keberhasilan edukasi kebiasaan tidur sehat menurut penelitian terkini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, indikator utama keberhasilan

edukasi tidur sehat adalah peningkatan skor kualitas tidur (PSQI) dan efisiensi tidur yang terukur secara statistik dan klinis (Silva, Martinez, & Loreda, 2022).

Penelitian terbaru oleh Chung, Lee, dan Yeung (2023) menunjukkan bahwa indikator signifikan keberhasilan intervensi edukasi adalah berkurangnya gejala insomnia kronis, ditandai dengan berkurangnya waktu untuk mulai tertidur (latensi tidur) serta berkurangnya durasi terbangun di malam hari. Indikator tambahan meliputi peningkatan pengetahuan pasien tentang praktik tidur sehat serta peningkatan tingkat kepatuhan pasien terhadap praktik yang disarankan.

Selain itu, keberhasilan edukasi juga tercermin dalam meningkatnya kualitas hidup secara umum, yang diukur melalui instrumen seperti SF-36 (*Short Form-36 Health Survey*). Studi oleh Matsuda dan Yoshida (2022) menunjukkan hubungan signifikan antara edukasi tidur sehat dengan peningkatan aspek emosional, fisik, dan sosial pada pasien yang mengalami gangguan tidur kronis.

3. Peran Teknologi Digital (Wearable Devices, Sleep Trackers) dalam Pemantauan Efektivitas Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat

Dalam beberapa tahun terakhir, peran teknologi digital dalam monitoring dan evaluasi kebiasaan tidur sehat semakin meningkat. Teknologi seperti wearable devices (perangkat yang dapat dikenakan seperti smartwatch) dan sleep trackers telah terbukti efektif dalam mengukur secara objektif pola tidur pasien, termasuk durasi tidur, siklus tidur, waktu terjaga, dan efisiensi tidur secara real-time (Baron et al., 2022).

Penelitian oleh Peters, Calvo, dan Ryan (2021) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam evaluasi edukasi tidur sehat tidak hanya meningkatkan akurasi data tetapi juga meningkatkan keterlibatan pasien dalam memantau dan memperbaiki kebiasaan tidur mereka. Wearable devices juga mampu memberikan umpan balik langsung kepada pasien, yang meningkatkan motivasi mereka untuk mempertahankan kebiasaan tidur yang sehat.

Penggunaan teknologi ini juga memberikan data objektif yang dapat digunakan tenaga kesehatan untuk menyesuaikan intervensi secara lebih personal dan efektif berdasarkan pola tidur aktual pasien. Menurut studi terbaru oleh Kang et al. (2021), penggunaan aplikasi berbasis mobile yang dilengkapi sleep tracker mampu meningkatkan kesadaran pasien akan pentingnya tidur sehat, serta secara signifikan memperbaiki pola tidur mereka dibandingkan pasien yang tidak menggunakan teknologi tersebut.

Oleh karena itu, integrasi teknologi digital dalam evaluasi efektivitas edukasi tidur sehat sangat dianjurkan sebagai bagian integral dari pendekatan berbasis bukti dalam manajemen gangguan tidur modern.

G. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Kebiasaan Tidur Sehat

1. Hambatan Umum dalam Proses Edukasi dan Perubahan Perilaku Pasien

Proses edukasi tidur sehat pada pasien yang mengalami gangguan tidur sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas intervensi. Hambatan ini umumnya meliputi aspek individu pasien, lingkungan sosial, serta sistem layanan kesehatan yang ada.

Menurut studi oleh Chung, Lee, dan Yeung (2023), hambatan utama yang sering ditemui pada individu pasien meliputi rendahnya kesadaran tentang pentingnya kebiasaan tidur sehat, motivasi rendah untuk mengubah perilaku, serta kesulitan mengubah kebiasaan lama yang sudah mengakar. Selain itu, adanya komorbiditas psikologis seperti kecemasan, depresi, atau stres kronis juga dapat menghambat penerapan kebiasaan tidur sehat secara konsisten (Irish et al., 2021).

Faktor lingkungan sosial seperti kurangnya dukungan keluarga, gaya hidup yang tidak teratur, tuntutan pekerjaan, dan faktor sosial budaya yang tidak mendukung pola tidur yang teratur, juga merupakan hambatan signifikan dalam proses edukasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lingkungan keluarga atau sosial yang kurang kondusif dapat secara signifikan menurunkan efektivitas edukasi tidur sehat yang diberikan (Silva, Martinez, & Loreda, 2022).

Di sisi lain, hambatan yang bersifat sistemik, seperti keterbatasan waktu tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi secara mendalam, terbatasnya sumber daya edukasi, serta kurangnya pelatihan yang memadai tentang komunikasi edukasi bagi tenaga kesehatan, turut menjadi tantangan dalam implementasi edukasi kebiasaan tidur sehat di fasilitas layanan kesehatan (Richards et al., 2021).

2. Strategi Mengatasi Hambatan Pasien dalam Menerapkan Kebiasaan Tidur Sehat

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam edukasi dan perubahan perilaku tidur pasien, berbagai strategi efektif dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan. Strategi ini mencakup pendekatan edukasi yang dipersonalisasi, peningkatan motivasi pasien, penguatan dukungan sosial, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi.

Penelitian terbaru oleh Bakken et al. (2021) merekomendasikan penerapan metode wawancara motivasional (*motivational interviewing*) sebagai strategi efektif untuk mengatasi hambatan individu, terutama dalam meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kepercayaan diri pasien dalam mengubah kebiasaan tidur yang tidak sehat. Strategi ini mendorong pasien untuk mengidentifikasi

sendiri keuntungan dari perilaku baru serta hambatan potensial yang dapat mereka hadapi, sehingga pasien merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam perubahan perilaku.

Strategi lain adalah melibatkan keluarga atau caregiver secara aktif dalam proses edukasi. Studi oleh Lau, Ariffin, dan Abidin (2021) menunjukkan bahwa edukasi yang melibatkan keluarga secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan kebiasaan tidur sehat. Keluarga dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif, mengingatkan pasien tentang jadwal tidur yang teratur, serta memberikan dukungan emosional yang kuat bagi pasien dalam proses perubahan perilaku.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan sistemik, tenaga kesehatan perlu didukung dengan pelatihan khusus tentang edukasi tidur sehat, peningkatan akses terhadap media edukasi digital, dan implementasi program edukasi terstruktur yang didukung oleh institusi layanan kesehatan. Menurut Peters, Calvo, dan Ryan (2021), penggunaan teknologi digital seperti aplikasi edukasi tidur sehat berbasis smartphone terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan waktu tenaga kesehatan, karena pasien dapat mengakses materi edukasi kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka.

Strategi-strategi ini, bila diterapkan secara sinergis dan terintegrasi, mampu secara efektif mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi edukasi kebiasaan tidur sehat, serta meningkatkan keberhasilan perubahan perilaku tidur pasien dalam jangka panjang.

H. Cara Mudah untuk Tenaga Keperawatan dalam Edukasi Tidur Sehat

1. Kompetensi Khusus yang Dibutuhkan Tenaga Keperawatan dalam Memberikan Edukasi Tidur Sehat

Dalam memberikan edukasi tidur sehat kepada pasien, tenaga keperawatan harus memiliki kompetensi khusus agar mampu memberikan intervensi edukasi yang efektif dan berbasis bukti. Kompetensi khusus tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam edukasi kesehatan tidur.

Kompetensi pertama yang wajib dimiliki oleh tenaga keperawatan adalah pemahaman mendalam tentang fisiologi tidur, gangguan tidur, serta berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, baik secara internal maupun eksternal (Richards et al., 2021). Pengetahuan ini menjadi dasar dalam menentukan jenis edukasi yang tepat serta menjawab pertanyaan pasien secara akurat dan meyakinkan.

Kedua, tenaga keperawatan harus menguasai keterampilan komunikasi terapeutik yang baik, termasuk kemampuan wawancara motivasional, konseling,

dan edukasi berbasis empati. Penelitian terbaru menegaskan bahwa kompetensi komunikasi terapeutik secara langsung berhubungan dengan keberhasilan edukasi kebiasaan tidur sehat (Bakken et al., 2021).

Ketiga, tenaga keperawatan harus mampu mengaplikasikan berbagai metode asesmen pola tidur pasien dengan menggunakan instrumen terstandar, seperti Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan Epworth Sleepiness Scale (ESS), serta mampu menginterpretasikan hasilnya secara klinis (Buysse et al., 2021; Johns, 2021).

Keempat, tenaga keperawatan harus memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi digital terkini seperti aplikasi edukasi, sleep tracker, dan wearable devices, yang dapat membantu memonitor pola tidur pasien secara efektif serta meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses edukasi (Baron et al., 2022).

Selain keterampilan teknis, tenaga keperawatan juga perlu memiliki sikap profesional seperti kesabaran, empati, fleksibilitas dalam menyesuaikan metode edukasi sesuai kebutuhan pasien, serta kemampuan kolaborasi interprofesional dalam tim kesehatan yang lebih luas (Richards et al., 2021).

2. Rekomendasi Panduan Klinis Terbaru Mengenai Edukasi Tidur Sehat di Fasilitas Layanan Kesehatan Primer hingga Tersier

Untuk memastikan kualitas edukasi tidur sehat yang konsisten dan efektif, tenaga keperawatan di semua jenjang layanan kesehatan—primer, sekunder, hingga tersier—disarankan mengikuti panduan klinis berbasis bukti terkini. Beberapa rekomendasi panduan terbaru yang relevan antara lain sebagai berikut:

Pertama, panduan klinis dari American Academy of Sleep Medicine (AASM, 2021) menegaskan bahwa edukasi tidur sehat harus menjadi intervensi pertama sebelum memulai intervensi farmakologis dalam penanganan gangguan tidur, terutama insomnia kronis. Panduan ini merekomendasikan bahwa edukasi tidur sehat diberikan secara terstruktur, menggunakan media edukasi interaktif, serta secara teratur dievaluasi efektivitasnya.

Kedua, rekomendasi terbaru dari National Sleep Foundation (NSF, 2021) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif pasien dalam proses edukasi melalui pendekatan self-management. Pasien harus didorong untuk secara mandiri memantau pola tidurnya menggunakan perangkat digital seperti aplikasi mobile atau wearable devices. Menurut NSF, pendekatan ini meningkatkan keterlibatan pasien, yang berdampak positif terhadap perubahan perilaku tidur yang berkelanjutan.

Ketiga, rekomendasi panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021) menyarankan agar fasilitas layanan primer secara rutin melakukan skrining gangguan tidur menggunakan instrumen sederhana serta memberikan edukasi dasar tidur sehat kepada semua pasien sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Keempat, panduan klinis terbaru untuk fasilitas layanan kesehatan tersier menekankan pentingnya integrasi intervensi psikologis seperti terapi perilaku kognitif (CBT-I) sebagai bagian utama dari edukasi tidur sehat, terutama pada pasien dengan insomnia kompleks atau gangguan tidur yang disertai gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan (Chung, Lee, & Yeung, 2023).

Implementasi panduan-panduan klinis ini secara konsisten di setiap jenjang layanan kesehatan, didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga keperawatan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas edukasi tidur sehat serta memperbaiki kualitas tidur pasien secara optimal.

I. Implikasi Praktik Keperawatan

1. Integrasi Hasil-Hasil Penelitian Terbaru tentang Edukasi Tidur Sehat dalam Praktik Keperawatan Klinis

Integrasi hasil penelitian terkini ke dalam praktik keperawatan klinis merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa intervensi edukasi tidur sehat yang diberikan oleh perawat sesuai dengan perkembangan bukti ilmiah terbaru. Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa edukasi tidur sehat tidak lagi sekadar intervensi tambahan, melainkan telah menjadi intervensi inti dalam manajemen pasien dengan berbagai jenis gangguan tidur, terutama insomnia kronis (Chung, Lee, & Yeung, 2023).

Berdasarkan penelitian Irish et al. (2021), edukasi tidur sehat yang diberikan secara sistematis mampu secara signifikan memperbaiki kualitas tidur pasien. Oleh karena itu, tenaga keperawatan harus secara aktif mengintegrasikan rekomendasi dari hasil penelitian terbaru ke dalam asesmen rutin pasien, intervensi keperawatan, serta evaluasi hasil intervensi secara berkala. Sebagai contoh, penelitian terbaru merekomendasikan integrasi terapi perilaku kognitif (CBT-I) ke dalam praktik keperawatan klinis sebagai bagian dari edukasi tidur sehat, yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pasien serta mengurangi gejala terkait insomnia (Richards et al., 2021).

Selain CBT-I, integrasi hasil penelitian tentang penggunaan teknologi digital juga direkomendasikan. Baron et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan teknologi seperti aplikasi seluler dan perangkat wearable membantu perawat dalam memonitor efektivitas intervensi edukasi tidur sehat serta memberikan

umpan balik secara real-time kepada pasien. Hal ini memungkinkan perawat untuk memberikan edukasi yang lebih personal, tepat sasaran, dan efektif berdasarkan data objektif pola tidur pasien.

Oleh karena itu, implikasi penting bagi praktik keperawatan adalah kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan yang berbasis bukti bagi tenaga keperawatan, serta pentingnya peran institusi kesehatan dalam memfasilitasi integrasi hasil penelitian terkini ke dalam protokol klinis sehari-hari.

2. Dampak Edukasi Tidur Sehat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Berdasarkan Evidence-Based Nursing

Edukasi tidur sehat memiliki dampak luas dan positif terhadap peningkatan kualitas hidup pasien. Berdasarkan pendekatan evidence-based nursing, penelitian terkini menunjukkan bahwa pasien yang menerima edukasi tidur sehat secara efektif mengalami peningkatan kualitas hidup secara signifikan, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga aspek emosional, sosial, dan psikologis (Matsuda & Yoshida, 2022).

Penelitian oleh Silva, Martinez, dan Loredó (2022) menunjukkan bahwa pasien yang mengikuti edukasi tidur sehat melaporkan penurunan signifikan dalam gejala kelelahan kronis, peningkatan energi di siang hari, serta perbaikan mood dan fungsi kognitif. Efek positif ini secara langsung berhubungan dengan peningkatan produktivitas sehari-hari, hubungan interpersonal yang lebih baik, serta peningkatan persepsi pasien terhadap kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam sebuah studi sistematis, Chung, Lee, dan Yeung (2023) juga menggarisbawahi bahwa edukasi tidur sehat yang dikombinasikan dengan intervensi psikologis seperti CBT-I secara konsisten menunjukkan manfaat jangka panjang terhadap kualitas hidup pasien, terutama pada pasien dengan insomnia yang disertai kecemasan atau depresi. Pasien melaporkan perasaan lebih positif tentang kehidupan, penurunan stres yang signifikan, serta peningkatan dalam kemampuan mengelola tantangan sehari-hari.

Menurut National Sleep Foundation (2021), edukasi tidur sehat juga berdampak pada penurunan risiko komplikasi kesehatan kronis seperti hipertensi, diabetes tipe 2, obesitas, dan gangguan kardiovaskular, yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup pasien dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan evidence-based nursing, perawat perlu secara proaktif memberikan edukasi tidur sehat kepada pasien dengan gangguan tidur sebagai bagian dari intervensi holistik. Praktik ini akan menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

J. Penutup

Edukasi kebiasaan tidur sehat merupakan aspek fundamental dalam manajemen keperawatan bagi pasien dengan gangguan tidur. Berbagai penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa edukasi tidur sehat, bila diimplementasikan secara sistematis dan berbasis bukti, mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas tidur pasien, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Irish et al., 2021; Matsuda & Yoshida, 2022).

Dalam praktik keperawatan modern, edukasi tidur sehat tidak dapat lagi dianggap sebagai intervensi tambahan yang bersifat opsional, melainkan harus diintegrasikan secara penuh dalam setiap tahap pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat primer hingga tersier. Intervensi edukasi yang paling efektif mencakup pendekatan yang komprehensif dan personal, seperti terapi perilaku kognitif (CBT-I), teknik relaksasi, serta penggunaan terapi komplementer berbasis bukti seperti aromaterapi, yoga, dan mindfulness (Chung, Lee, & Yeung, 2023; Talwar, Sen, & Singh, 2020).

Peran teknologi digital dalam mendukung edukasi tidur sehat juga semakin relevan, terutama melalui pemanfaatan perangkat wearable, sleep trackers, dan aplikasi mobile. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pemantauan pola tidur pasien secara objektif, meningkatkan keterlibatan pasien, serta membantu tenaga keperawatan menyesuaikan edukasi secara personal dan tepat sasaran (Baron et al., 2022).

Meski demikian, implementasi edukasi tidur sehat dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari faktor individu pasien maupun lingkungan dan sistem layanan kesehatan. Strategi mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kompetensi tenaga keperawatan dalam komunikasi terapeutik dan edukasi, melibatkan keluarga atau caregiver secara aktif, serta mengintegrasikan pendekatan wawancara motivasional untuk meningkatkan motivasi pasien dalam perubahan perilaku (Bakken et al., 2021; Lau, Ariffin, & Abidin, 2021).

Rekomendasi praktis bagi tenaga keperawatan menekankan perlunya kompetensi khusus, pelatihan berbasis bukti, serta penerapan panduan klinis terbaru agar edukasi tidur sehat dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di semua tingkatan layanan kesehatan. Hal ini menuntut institusi kesehatan menyediakan fasilitas pendukung serta sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi edukasi tersebut secara optimal (Richards et al., 2021).

Akhirnya, hasil-hasil penelitian terbaru memberikan implikasi nyata bagi praktik keperawatan klinis, menegaskan pentingnya integrasi edukasi tidur sehat

sebagai standar praktik dalam pelayanan keperawatan. Edukasi tidur sehat terbukti efektif tidak hanya dalam mengatasi gangguan tidur secara klinis tetapi juga berdampak luas dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, yang menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan berbasis bukti (Silva, Martinez, & Loreda, 2022; National Sleep Foundation, 2021).

Dengan demikian, penerapan edukasi tidur sehat secara sistematis dan berkelanjutan diharapkan mampu mengurangi beban kesehatan akibat gangguan tidur, serta memberikan manfaat jangka panjang yang nyata bagi kualitas hidup pasien dan keluarganya.

Referensi

- Bakken, L. N., Kim, H. S., Finset, A., & Lerdal, A. (2021). Motivational interviewing in managing insomnia: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(5–6), 589–603. <https://doi.org/10.1111/jocn.15649>
- Baron, K. G., Duffecy, J., Richardson, D., Avery, E., & Rothschild, S. (2022). Mobile technology to enhance behavioral therapy for insomnia: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 63, 101640. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2022.101640>
- Buysse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (2021). The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): Reliability and validity in clinical practice and research. *Sleep Medicine Reviews*, 58, 101516. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101516>
- Chung, K. F., Lee, C. T., & Yeung, W. F. (2023). Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I): Recent advancements and implications for clinical practice. *Journal of Sleep Research*, 32(1), e13789. <https://doi.org/10.1111/jsr.13789>
- Irish, L. A., Kline, C. E., Gunn, H. E., Buysse, D. J., & Hall, M. H. (2021). The role of sleep hygiene education in managing insomnia and improving sleep quality: A meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*, 59, 101517. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101517>
- Johns, M. W. (2021). Epworth Sleepiness Scale: Reliability and validity revisited. *Sleep Medicine*, 80, 167–175. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.01.048>
- Karadag, E., Samancioglu, S., Ozden, D., & Bakir, E. (2021). Effects of aromatherapy on sleep quality: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Medicine*, 56, 102599. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102599>
- Kim, E. J., & Dimsdale, J. E. (2020). The effect of anxiety and depression on sleep disorders: A systematic review. *Sleep Disorders*, 2020, 8436123. <https://doi.org/10.1155/2020/8436123>
- Lau, J. H., Ariffin, F., & Abidin, E. Z. (2021). Family support and adherence to sleep hygiene among elderly patients with insomnia: a cross-sectional study. *International Journal of Gerontology*, 15(2), 142–147. [https://doi.org/10.6890/IJGE.202104_15\(2\).0012](https://doi.org/10.6890/IJGE.202104_15(2).0012)
- Liu, K., Chen, Y., Wu, D., Lin, R., & Wang, Z. (2020). Effects of progressive muscle relaxation on anxiety and sleep quality in patients with COVID-19: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 39, 101132. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101132>
- Matsuda, R., & Yoshida, M. (2022). Effectiveness of sleep hygiene interventions on sleep quality among adults with sleep disorders: A systematic review and meta-

- analysis. *Journal of Clinical Nursing*, 31(3–4), 426–441. <https://doi.org/10.1111/jocn.16054>
- Peters, D., Calvo, R. A., & Ryan, R. M. (2021). Developing digital interventions for sleep hygiene: A review of evidence and recommendations. *Journal of Medical Internet Research*, 23(4), e23521. <https://doi.org/10.2196/23521>
- Richards, K. C., Vallury, K. D., Christensen, M., & van den Berg, M. E. L. (2021). Nurse-led education for insomnia: A systematic review. *Sleep Health*, 7(3), 273–282. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2021.03.005>
- Silva, G. E., Martinez, D., & Lored, J. S. (2022). Sleep hygiene education to improve sleep quality among hospitalized patients: A randomized controlled trial. *Clinical Nursing Research*, 31(2), 212–223. <https://doi.org/10.1177/10547738211021004>
- Talwar, P., Sen, M. K., & Singh, R. (2020). The role of mindfulness-based interventions in improving sleep quality among chronic insomnia patients: A systematic review. *Sleep Disorders*, 2020, 8673654. <https://doi.org/10.1155/2020/8673654>
- Toma, C. L., & Wu, T. Y. (2023). Effect of educational mobile apps on sleep hygiene practices among college students. *Journal of Nursing Scholarship*, 55(1), 84–93. <https://doi.org/10.1111/jnu.12820>
- Wang, W. L., Chen, K. H., Pan, Y. C., Yang, S. N., & Chan, Y. Y. (2020). The effect of yoga on sleep quality and insomnia: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 20(1), 195. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02542-8>
- Xie, Y., Tang, Q., Chen, G., Xie, M., & Yu, S. (2021). Association between circadian rhythm disruption and insomnia: A meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 717544. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.717544>
- American Academy of Sleep Medicine (AASM). (2021). *Clinical Practice Guideline for the Treatment of Insomnia in Adults*. American Academy of Sleep Medicine.
- Lee, M., Kim, J., & Kim, H. (2022). *Therapeutic communication in nursing practice: principles and evidence-based practices (2nd ed.)*. Springer Publishing Company.
- National Sleep Foundation (NSF). (2021). *Healthy Sleep Guidelines*. Diakses dari: <https://www.sleepfoundation.org/sleep-guidelines-covid-19-isolation>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing (10th ed.)*. Elsevier Mosby.
- World Health Organization (WHO). (2021). *WHO Technical Meeting on Sleep and Health*. Diakses dari: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240035033>

BAB III

DUKUNGAN PSIKOLOGIS

UNTUK PASIEN DENGAN GANGGUAN TIDUR KRONIS

A. Pendahuluan

Salah satu kebutuhan dasar biologis manusia adalah tidur. Tidur merupakan suatu fenomena biologis yang berkaitan erat dengan irama alam semesta, yang bersiklus 24 jam mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Manusia sebagai makhluk yang baraktifitas memerlukan istirahat yang cukup, untuk memulihkan kembali staminanya. Seseorang tidak selamanya dapat menikmati tidur dengan baik ataupun sempurna. Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami ketidaksempurnaan dalam istirahatnya, atau hal ini biasa dikenal dengan sebutan gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan suatu kondisi dimana manusia mengalami gangguan untuk masuk tidur dan mempertahankan tidurnya (SAFRUDIN dkk., 2023).

Gangguan tidur akan berdampak pada munculnya beberapa permasalahan pada seseorang. Beberapa permasalahan yang muncul akibat gangguan tidur seperti mengganggu aktivitas sehari-hari pasien, sekaligus memberi pengaruh bagi tubuh baik dari sisi psikologis, fisiologis, sosial, sekaligus spiritual serta bisa berimplikasi bagi penampilan yang menurun mencakup disfungsi kognitif, mudah marah, kewaspadaan dan konsentrasi menurun, dan memperparah keadaan penyakit (Istiroha dkk., 2024). Selain itu, Alif dkk. (2022) juga menyebutkan gangguan tidur akan berdampak pada fisik maupun psikologis. Dampak fisik gangguan tidur dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk pemulihan yang tidak memadai, yang dapat mengakibatkan perasaan lemas, pusing, mengantuk, dan lelah. Selain itu, dampak psikologis dari gangguan tidur dapat berupa kecemasan, mudah tersinggung, kesulitan berkonsentrasi, dan peningkatan tingkat stres, yang semuanya dapat meningkatkan risiko pikiran untuk bunuh diri (Alif dkk., 2022).

Gangguan tidur dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya gangguan psikologis. Gangguan psikologi dapat meningkatkan risiko individu mengalami gangguan tidur atau sebaliknya gangguan tidur dapat pula meningkatkan risiko individu mengalami gangguan psikologis dan emosi. Kedua gangguan ini saling berkaitan dan dapat menyebabkan gangguan utama atau gangguan penyerta. Gejala gangguan psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, dan *PTSD* (*Post*

Traumatic Stress Disorder) dapat menyebabkan individu sulit tidur, sulit menjaga ritme tidur, memiliki kualitas tidur yang buruk, mimpi buruk, dan mengantuk sepanjang hari (Hapsari dan Kurniawan, 2019). Faktor psikologis memainkan peran penting dalam perkembangan insomnia. Hal ini dapat dipicu oleh stres, perubahan hormonal, atau kondisi kesehatan kronis. Insomnia tergolong kronis jika terjadi tiga malam atau lebih dalam seminggu selama jangka waktu satu bulan. Salah satu penyebab umum insomnia kronis adalah depresi (Wahyuningrum dkk., 2017).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan tidur adalah dengan memberikan dukungan psikologis. Salah satu cara efektif untuk mencegah gangguan tidur adalah dengan memberikan dukungan psikologis. Dukungan ini melibatkan pemberian perhatian, bantuan motivasi, informasi bermanfaat, interaksi positif, dan sumber daya dari anggota keluarga atau orang lain, yang semuanya dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Selain itu, dukungan psikologis dicirikan sebagai pertukaran antarpribadi yang mencakup perhatian emosional, bantuan praktis, informasi yang relevan, dan evaluasi untuk penilaian diri (Afifah dan Luawo, 2020). Dukungan psikologis dimaksudkan untuk mencegah memburuknya kesehatan mental seseorang. Dukungan ini membantu individu merasa lebih baik, aman, dan nyaman sekaligus memungkinkan mereka untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mendukung dorongan ketenangan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan sosial, fisik, dan emosional, memungkinkan individu mendapatkan kembali rasa kendali dan memberdayakan mereka untuk membantu diri mereka sendiri (Nuraeni dan Endriani, 2024).

B. Gangguan Tidur

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar dimana reaksi dan persepsi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya berkurang atau bahkan hilang. Keadaan ini dapat dipulihkan dengan masukan atau stimulasi sensorik yang memadai. Tidur sering kali ditandai dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan berkurangnya respons terhadap rangsangan eksternal. Seseorang dikatakan memiliki kualitas tidur yang baik jika tidak menunjukkan tanda-tanda kurang tidur dan tidak mengalami kesulitan untuk tertidur atau tetap tertidur (Nurfantri dkk., 2022).



Gambar 1.1 Gangguan tidur

Sumber: <https://hellosehat.com/pola-tidur/gangguan-tidur/pengertian-gangguan-tidur/>

Gangguan tidur adalah sekelompok kondisi yang melibatkan gangguan pola tidur seseorang, sehingga memengaruhi durasi, kualitas, atau waktu tidur. Kuantitas tidur mengacu pada durasi tidur yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan sesuai usia, yang dapat dipengaruhi oleh kesulitan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Transisi antara bangun dan tidur melibatkan proses saraf yang kompleks. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat mengganggu Ascending Reticular Activating System (ARAS), meningkatkan kewaspadaan dan membuat sulit tertidur (Kemenkes RI, 2022). Gangguan tidur yang berlangsung selama 3 malam atau lebih dapat dikatakan gangguan tidur kronis (Wahyuningrum dkk., 2017).

C. Faktor yang Mempengaruhi Gangguan Tidur

Hasibuan dan Hasna (2021) menyebutkan gangguan tidur dapat dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

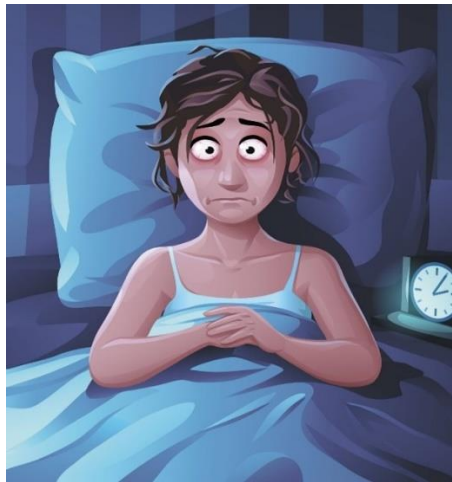
1. Usia
2. konsumsi kafein
3. psikiatri (depresi, stress, gangguan anxietas)
4. kondisi medis (penyakit paru, hipertensi, penyakit neurologi, diabetes mellitus, penyakit jantung, obesitas, hipertiroid)
5. lingkungan (cahaya, suhu)
6. konsumsi alkohol
7. konsumsi obat-obatan
8. pola makan

D. Klasifikasi Gangguan Tidur

Kemenkes RI (2022) menyebutkan gangguan tidur dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Insomnia

Kesulitan tidur, tetap tertidur, atau mengalami gangguan tidur dapat membuat individu merasa belum cukup istirahat saat bangun tidur. Gejala fisiknya antara lain wajah pucat, mata bengkak, badan lemas, dan daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Gejala psikologis dapat bermanifestasi sebagai kelesuan, reaksi lambat terhadap rangsangan, dan kesulitan berkonsentrasi.



Gambar 1.2 Insomnia

Sumber: <https://neurologi.fk.uns.ac.id/i/insomnia>

2. Hipersomnia

Gangguan yang ditandai dengan tidur berlebihan dan kantuk terus-menerus di siang hari dikenal sebagai narkolepsi. Kondisi ini melibatkan keinginan tidur yang tidak terkendali dan dapat terjadi pada usia berapa pun. Gejala fisiknya antara lain perasaan mengantuk yang intens, gelisah, dan depresi, rendahnya harga diri dan tidak bisa bergerak, ditandai dengan ketidakmampuan bergerak saat pertama kali bangun. Gejala psikis mungkin melibatkan halusinasi visual atau pendengaran.



Gambar 1.3 Hipersomnia

Sumber: <https://www.alodokter.com/hipersomnia>

3. Parasomnia

Gangguan tidur yang langka dan tidak diinginkan dapat tiba-tiba muncul saat tidur atau pada batas antara terjaga dan tidur, sering kali muncul melalui mimpi yang menakutkan. Gejala fisik dapat berupa berjalan dalam tidur, berbicara saat tidur, atau tiba-tiba duduk di tempat tidur, sedangkan gejala psikologis berupa fakta bahwa penderita jarang mengingat peristiwa yang terjadi selama episode tersebut.



Gambar 1.4 Parasomnia

Sumber: <https://hellosehat.com/pola-tidur/gangguan-tidur/pengertian-parasomnia/>

Gangguan tidur yang sering dialami adalah Insomnia yang penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari akibat gaya hidup, masalah kenyamanan ruang kamar, hingga adanya gangguan psikologi, masalah kesehatan fisik dan efek obat-obatan.

E. Dampak Gangguan Tidur

Kemenkes (2021) menyebutkan gangguan tidur akan menyebabkan seseorang mengalami beberapa permasalahan kesehatan. beberapa permasalahan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.5 Permasalahan gangguan tidur

Sumber: <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stres/kenali-7-ancaman-akibat-kurang-tidur>

1. Hilang konsentrasi saat belajar
2. Munculnya obesitas
3. Hilang fokus saat berkendara
4. Kulit terlihat lebih tua
5. Sering lupa
6. Stres yang meningkat

F. Dukungan Psikologis



Gambar 1.6 Dukungan psikologis

Sumber: <https://www.halodoc.com/artikel/pentingnya-dukkungan-psikologis-bagi-ibu-pasca-hamil-ektopik>

Dukungan psikologis adalah metode membantu seseorang yang berada dalam keadaan distres, membantu mereka merasa tenang dan didukung saat mereka menghadapi tantangan atau masalah. Jenis dukungan ini memungkinkan individu untuk mengelola situasi mereka secara efektif dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. Dukungan ini membantu menstabilkan kecemasan dan emosi lainnya, mendorong perilaku manajemen diri yang sehat, memberikan rasa aman, menenangkan pikiran, dan menumbuhkan harapan (Adni dkk., 2020).

Kebutuhan akan dukungan psikologis muncul dari keinginan individu untuk memperoleh energi positif dari orang lain yang dapat membantunya mengatasi masalah yang dihadapinya. Jika kebutuhan akan dukungan ini tidak dipenuhi secara komprehensif, hal ini dapat menyebabkan semakin disfungsionalnya perilaku dan mungkin memerlukan bantuan tenaga profesional yang lebih bervariasi (Afifah dan Luawo, 2020).

G. Prinsip Pelaksanaan Dukungan Psikologi

Adni dkk. (2020) menyebutkan pelaksanaan dukungan psikologis memiliki beberapa prinsip dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis. Beberapa prinsip tersebut meliputi:

1. Lihat, mengacu pada bagaimana menilai:
 - a. Situasi saat ini
 - b. Siapa yang mencari bantuan
 - c. Apa saja resiko yang dihadapi klien/penyintas
 - d. Kebutuhan dari orang yang terdampak
 - e. Reaksi emosi yang wajar muncul
2. Dengarkan, mengacu pada bagaimana:
 - a. Memulai percakapan
 - b. Pemberi Layanan memperkenalkan diri
 - c. Memberikan perhatian dan mendengarkan secara aktif
 - d. Menerima perasaan atau emosi
 - e. Menenangkan seseorang yang ada dalam situasi distres
 - f. Menanyakan mengenai kebutuhan dan keprihatinan
 - g. Membantu menemukan solusi akan kebutuhan dan permasalahan
3. Hubungkan, mengacu pada bagaimana membantu dengan:
 - a. Mengakses informasi
 - b. Menghubungkan dengan orang tercinta dan dukungan sosial
 - c. Menangani masalah praktis

- d. Mengakses layanan dan bantuan lain.

H. Faktor Psikologis Dan Sosial Yang Mempengaruhi Keadaan Psikologis Seseorang

Khasanah dkk. (2023) menyebutkan keadaan psikologis seseorang dapat dipengaruhi oleh psikologis orang itu sendiri dan keadaan sosialnya. Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang:

1. Faktor Psikologis:

- a. Riwayat Kehidupan: Pengalaman masa lalu, termasuk trauma, kehilangan, atau kejadian penting lainnya, dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang.
- b. Kepribadian: Tipe kepribadian, seperti tingkat ekstrasversi atau neurotisme, dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespons situasi dan mengatur emosi mereka.
- c. Proses Kognitif: Cara seseorang berpikir, mempersepsikan, dan menginterpretasikan dunia dapat mempengaruhi keadaan psikologis mereka. Faktor seperti keyakinan negatif tentang diri sendiri atau kecenderungan pemikiran yang maladaptif dapat berkontribusi pada masalah psikologis.
- d. Stres: Tingkat stres yang tinggi dan ketidakmampuan mengelola stres dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis seseorang.
- e. Coping Skills: Kemampuan seseorang dalam mengatasi tantangan dan mengelola emosi dapat mempengaruhi keadaan psikologis mereka. Individu yang memiliki keterampilan penyesuaian diri yang efektif cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik.

2. Faktor Sosial:

- a. Dukungan Sosial: Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial dapat memiliki pengaruh positif pada keadaan psikologis seseorang. Kurangnya dukungan sosial atau hubungan sosial yang buruk dapat berkontribusi pada masalah psikologis.
- b. Lingkungan Sosial: Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan lingkungan, atau kekerasan dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang.
- c. Norma Sosial dan Budaya: Norma sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi individu tentang diri mereka sendiri, hubungan sosial, dan kepuasan hidup mereka.
- d. Diskriminasi dan Stigma: Diskriminasi atau stigmatisasi yang dialami oleh seseorang berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau kondisi mental dapat mempengaruhi keadaan psikologis mereka secara negatif.

I. Faktor Pendorong Pemberian Dukungan Psikologis

Afifah dan Luawo (2020) menyebutkan terdapat 3 faktor penting pendorong pemberian dukungan psikologis diantaranya:

1. Empati adalah kemampuan untuk merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan memahami emosi dan motivasi mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi penderitaan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
2. Norma dan nilai sosial menjadi pedoman penting yang membantu dan membimbing individu memenuhi kewajibannya dalam hidup.
3. Pertukaran sosial mengacu pada sifat timbal balik dari interaksi sosial, yang mencakup cinta, layanan, dan informasi. Pertukaran yang seimbang memupuk hubungan interpersonal yang memuaskan. Pengalaman timbal balik ini membangun kepercayaan diri individu bahwa mereka dapat mengandalkan dukungan orang lain.

J. Bentuk Dukungan Psikologis

Khasanah dkk. (2023) menyebutkan terdapat beberapa bentuk dukungan psikologis dan emosional. Beberapa bentuk dukungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Empati

Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dialami orang lain, seolah-olah kita juga mengalami hal yang sama. Ini melibatkan berbagi emosi seseorang tanpa melakukan tindakan untuk meringankan beban mereka

2. Peduli

Peduli merujuk pada sikap dan tindakan dalam menghargai apa yang dibutuhkan orang lain. Ini melibatkan memberikan bantuan dan dukungan langsung kepada seseorang yang menghadapi kesulitan

3. Perhatian

Perhatian adalah sikap positif untuk fokus pada orang lain. Ini ditunjukkan melalui perhatian dan pertimbangan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi situasi yang menantang

4. Penghargaan Positif

Penghargaan positif melibatkan ekspresi perasaan hangat, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta terhadap orang lain. Ini melibatkan menunjukkan kasih sayang, cinta, pujian, atau persetujuan dari orang lain dan merasa kecewa ketika dihadapkan dengan kritik atau kurangnya kasih sayang

5. Dorongan terhadap Orang Lain

Sikap ini melibatkan memotivasi dan membimbing orang lain agar tetap fokus dalam mencapai tujuan mereka. Ini membantu individu yang menghadapi masalah merasa didukung dan nyaman dalam perjalanan mereka

Sedangkan Afifah dan Luawo (2020) menyebutkan bentuk dukungan psikologis antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan Emosional

Dukungan emosional melibatkan ekspresi perasaan positif, menunjukkan pemahaman empati, dan mendorong ekspresi emosi. Jenis dukungan ini mencakup perhatian, cinta, dan empati.

2. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental, sering disebut sebagai dukungan nyata, adalah tentang menyediakan barang-barang atau sumber daya penting yang dapat membantu pengobatan anak. Dukungan ini mungkin termasuk menawarkan makanan, pakaian, atau bantuan keuangan.

3. Dukungan Informasi

Dukungan informasi memberikan panduan atau umpan balik yang dapat membantu mengatasi masalah tertentu. Jenis dukungan ini biasanya mencakup berbagi informasi tentang suatu penyakit dan pilihan pengobatan yang tersedia.

4. Dukungan Penilaian

Dukungan penilaian mencakup penawaran informasi yang membantu evaluasi diri, membantu individu menilai kemampuan dan kemajuan mereka sendiri.

5. Interaksi Sosial yang Mendukung

Interaksi sosial yang suportif ditandai dengan hubungan persahabatan dan aktivitas yang menyenangkan dengan orang lain. Bentuk dukungan ini sering kali melibatkan partisipasi dalam aktivitas rekreasi dan menyenangkan, yang dapat memberikan rasa tenang dan perspektif baru bagi seseorang yang mengalami stres.

K. Sumber Dukungan Psikologis

Afifah dan Luawo (2020) menyebutkan terdapat beberapa sumber dalam memberikan dukungan psikologis pada seseorang. Beberapa sumber tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa antara lain sebagai berikut:

1. Orang-orang dalam kehidupan individu yang bersifat non-profesional antara lain adalah anggota keluarga, orang tua, pasangan (suami atau istri), teman dekat, dan rekan kerja. Hubungan-hubungan ini sering kali menyita sebagian besar kehidupan seseorang dan dapat menjadi sumber dukungan yang berharga.



Gambar 1.7 Dukungan psikologis orang terdekat

Sumber: <https://canhope.kompas.id/baca/2025/01/18/pentingnya-duktungan-keluarga-dalam-pemulihan-kanker-paru-stadium-4/>

2. Profesional seperti psikolog, konselor, dan dokter sangat bermanfaat untuk analisis klinis dan psikologis.



Gambar 1.8 Dukungan psikologis tenaga profesional

Sumber: <https://www.alodokter.com/memanfaatkan-konsultasi-psikologi-untuk-meningkatkan-kesehatan-mental>

3. Kelompok pendukung sosio-psikologis, seperti pekerja sosial di LSM, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang belum pernah ditemui individu sebelumnya.



Gambar 1.9 Dukungan psikologis tenaga profesional

Sumber: <https://homecaregenerations.com/how-to-build-a-social-support-network-for-your-elderly-loved-one/>

L. Hubungan Dukungan Psikologis Dengan Gangguan Tidur Kronis

Dukungan psikologis adalah teknik yang digunakan untuk membantu individu dalam situasi stres untuk merasa tenang dan didukung, sehingga memungkinkan mereka mengatasi tantangan dengan lebih baik. Dukungan ini dapat menstabilkan kecemasan dan emosi lainnya sekaligus mendorong perilaku manajemen diri yang sehat. Selain itu, dukungan psikologis memberikan rasa aman, menanamkan ketenangan, dan menumbuhkan harapan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. (Adni dkk., 2020). Kesejahteraan Psikologis memiliki manfaat dalam melindungi kesehatan, salah satunya termasuk produksi kortisol yang rendah, penurunan respons terhadap stres kardiovaskular, dan peningkatan respons antibodi terhadap vaksinasi (Steptoe dkk., 2008). Seseorang yang mengalami penurunan kesejahteraan psikologi (stres) dapat berakibat pada penurunan kualitas tidur. Kualitas tidur seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu psikologis, agama. Kualitas tidur dapat dipengaruhi oleh keadaan psikologis seperti kecemasan, ketakutan, depresi dan tekanan emosional (stress). Apabila keadaan tersebut dapat ditangani maka tidak akan mengalami gangguan tidur akibat sering terbangun akibat pikiran-pikiran negative yang belum tentu terjadi sehingga pemenuhan kebutuhan tidur dapat meningkat lebih baik (Kurnia dkk., 2024).

M. Penutup

Gangguan tidur kronis merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan tidur yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Gangguan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan

depresi. Dampak dari gangguan tidur meliputi masalah fisik (kelelahan, penurunan daya tahan tubuh) dan psikologis (mudah marah, kurang konsentrasi, hingga peningkatan risiko bunuh diri). Dukungan psikologis memainkan peran penting dalam membantu individu mengatasi gangguan tidur. Bentuk dukungan ini meliputi dukungan emosional, informasi, instrumental, dan penilaian. Dukungan dapat diberikan oleh keluarga, teman, tenaga profesional, serta kelompok sosial. Dengan adanya dukungan yang memadai, seseorang dapat mengelola stres, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas tidurnya.

Referensi

- Adni, A., A. Asrori, dan G. T. Pratiwi. 2020. Dukungan psikologis awal (psychological first aid - pfa) jarak jauh selama pandemi covid-19. *Psychosocial Center*. 3(1):129.
- Afifah, W. dan M. I. R. Luawo. 2020. Profil dukungan sosial-psikologis yang dibutuhkan dan diperoleh orangtua dengan anak sakit kanker (survey di komunitas kantong doraemon). *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*. 9(1):94–107.
- Alif, M. A., Z. Abidin, dan A. Astuti. 2022. The effectiveness of exercise on sleep quality in the elderly: literature review. *Indonesian Journal of Health Care Management (IJOHCN)*. 3(1):1–6.
- Hapsari, A. dan A. Kurniawan. 2019. Efektivitas cognitive behavior therapy (cbt) untuk meningkatkan kualitas tidur penderita gejala insomnia usia dewasa awal. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*. 12(3):223–235.
- Hasibuan, R. K. dan J. A. Hasna. 2021. Gambaran kualitas tidur pada lansia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kecamatan kayangan, kabupaten lombok utara, nusa tenggara barat. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*. 17(2):187.
- Istiroha, Sutrisno, A. H. Basri, dan R. Zahroh. 2024. GANGGUAN tidur dan kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di wilayah kabupaten gresik. *Jurnal Keperawatan*
- Kemendes. 2021. Kenali 7 Ancaman Akibat Kurang Tidur. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stres/kenali-7-ancaman-akibat-kurang-tidur>
- Kemendes RI. 2022. Yuks... Mengenal Gangguan Tidur. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/502/yuks-mengenal-gangguan-tidur
- Khasanah, N., R. W. Widayati, A. S. Fitriawan, dan E. N. Syafitri. 2023. Psikososial Dalam Keperawatan
- Kurnia, E. A., A. Siswoaribowo, dan D. Rachmania. 2024. Hubungan ketenagan jiwa dengan kualitas tidur pada lansia di lembaga kesejahteraan lanjut usia (lkslu) di kabupaten nganjuk. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*. 28–38.
- Nuraeni dan A. Endriani. 2024. Dukungan psikologis awal untuk anak dan remaja. *Jurnal Dedikasi Madani*. 3(1):46–51.
- Nurfantri, Ernawati, Ahmadi, A. M. P. Pelawi, F. M. Simanjuntak, R. L. Siantar, E. A. Mawardi, R. Siregar, T. R. Aritonang, N. C. Nurvitriana, Y. Widjayanti, K. Deniati, H. Nisa, E. Meliyana, dan L. Indrawati. 2022. *Keperawatan Dasar*. Malang: Rena Cipta Mandiri.
- SAFRUDIN, S., R. ROSIDAWATI, dan A. AZIZ. 2023. Faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan tidur pada ibu post partum hari pertama sampai hari ketiga

- di puskesmas kelurahan aren jaya bekasi timur tahun 2020. Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP). 1(3):203–212.
- Steptoe, A., K. O'Donnell, M. Marmot, dan J. Wardle. 2008. Positive Affect, Psychological Well-Being, and Good Sleep. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399907004515>
- Wahyuningrum, T., N. Saudah, dan L. Hermansyah. 2017. Hubungan tingkat depresi dengan gangguan tidur (insomnia) pada lansia di upt panti werdha “mojopahit” kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmu Kesehatan. 4(1):50.

BAB IV

KOLABORASI TENAGA MEDIS DALAM PENGELOLAAN PASIEN DENGAN GANGGUAN TIDUR

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Pendekatan Kolaboratif Interprofesional dalam Manajemen Gangguan Tidur

Gangguan tidur merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan melibatkan banyak faktor penyebab, seperti kondisi medis, psikologis, lingkungan, hingga kebiasaan hidup pasien. Dalam mengelola kondisi ini, dibutuhkan pendekatan kolaboratif interprofesional yang melibatkan berbagai tenaga medis seperti dokter, perawat, psikolog, ahli farmasi, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi berbagai disiplin ilmu dalam memberikan asuhan pasien secara holistik, efektif, dan efisien (Martínez et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional dapat meningkatkan hasil klinis, meningkatkan kepuasan pasien, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam manajemen gangguan tidur, seperti insomnia, sleep apnea, dan gangguan tidur lain yang bersifat kronis. Sebuah studi oleh Galbiati et al. (2023) menyatakan bahwa tim interprofesional yang bekerja secara terpadu mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pasien terhadap terapi, menurunkan angka kambuhan, dan meningkatkan efektivitas terapi jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan yang tidak terintegrasi.

World Health Organization (WHO, 2020) juga merekomendasikan kolaborasi interprofesional sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, khususnya dalam penanganan penyakit kronis, termasuk gangguan tidur. Kolaborasi ini membantu memperjelas peran masing-masing tenaga medis, mengurangi kesenjangan informasi, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam tim, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi pasien (Siciliano et al., 2022).

2. Dampak Gangguan Tidur terhadap Kualitas Hidup Pasien dan Urgensi Kolaborasi Tenaga Medis

Gangguan tidur memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Studi terbaru menunjukkan bahwa pasien yang mengalami gangguan tidur memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti depresi, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, gangguan kecemasan, dan penurunan fungsi kognitif (Baglioni et al., 2021). Selain itu, gangguan tidur yang tidak ditangani secara efektif dapat menurunkan produktivitas kerja, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menurunkan kualitas hubungan interpersonal pasien, sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan kehidupan sosial pasien (Cox et al., 2022).

Dalam konteks ini, urgensi kolaborasi tenaga medis dalam manajemen gangguan tidur menjadi sangat penting. Studi yang dilakukan oleh Patel et al. (2020) mengungkapkan bahwa manajemen gangguan tidur yang dilakukan secara kolaboratif dapat mengidentifikasi permasalahan pasien secara komprehensif serta merancang intervensi multidimensi yang mencakup aspek medis, psikologis, farmakologis, dan nonfarmakologis. Dengan pendekatan kolaborasi ini, tim medis mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasien, serta memberikan edukasi yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kualitas tidur untuk meningkatkan kualitas hidup (Wu & Zaslawski, 2021).

Lebih jauh, urgensi kolaborasi ini diperkuat dengan adanya kompleksitas terapi pada gangguan tidur yang sering kali memerlukan pendekatan gabungan antara terapi perilaku, farmakologi, edukasi kesehatan, hingga terapi nutrisi (Young et al., 2021). Dalam kolaborasi interprofesional, masing-masing tenaga medis membawa keahliannya untuk mendukung tercapainya tujuan terapi yang optimal bagi pasien.

Melihat urgensi tersebut, pendekatan kolaborasi interprofesional tidak hanya penting namun juga merupakan kebutuhan dalam menjawab tantangan kompleksnya manajemen gangguan tidur. Kolaborasi yang efektif akan memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, mempercepat proses pemulihan, dan secara signifikan memperbaiki kualitas hidup pasien (Galbiati et al., 2023; Martínez et al., 2021).

B. Prinsip-Prinsip Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Gangguan Tidur

1. Dasar Teori dan Konsep Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Tidur

Kolaborasi interprofesional dalam keperawatan tidur didasarkan pada teori dan konsep interprofessional collaboration (IPC), yang menekankan pentingnya integrasi peran antarprofesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien secara menyeluruh. Secara konseptual, IPC merujuk pada suatu proses kerja sama

di mana tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu bekerja secara sinergis, berbagi tanggung jawab, menetapkan tujuan bersama, dan berkontribusi secara kolektif dalam pengambilan keputusan klinis (Reeves et al., 2021).

Dalam konteks gangguan tidur, pendekatan ini sangat relevan karena gangguan tidur memiliki etiologi kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari faktor biologis hingga psikososial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan IPC dalam manajemen gangguan tidur mampu menghasilkan asuhan keperawatan yang lebih efektif dan efisien, ditandai dengan perbaikan hasil klinis, peningkatan kepatuhan terapi, serta kualitas hidup pasien yang lebih baik (Barthélemy et al., 2022).

Teori kolaborasi interprofesional yang umum digunakan adalah Collaborative Practice Model (CPM), yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi terbuka, saling percaya, menghormati perbedaan kompetensi profesional, dan mengedepankan tujuan bersama dalam perawatan pasien (Bridges et al., 2020). Penerapan CPM dalam pengelolaan gangguan tidur mengarahkan tim interprofesional untuk melakukan asesmen komprehensif, merencanakan intervensi yang terpadu, serta mengevaluasi efektivitas manajemen secara bersama-sama (Harrington & Dolansky, 2021).

Selain CPM, konsep Patient-Centered Care juga menjadi dasar penting dalam IPC yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan terapi (Braaf et al., 2020). Dalam konteks keperawatan tidur, pendekatan ini memungkinkan pasien lebih memahami kondisi yang dialaminya, yang selanjutnya meningkatkan tingkat partisipasi dalam terapi yang direkomendasikan tim kolaboratif.

2. Kompetensi Utama Tenaga Kesehatan dalam Kolaborasi Penanganan Gangguan Tidur

Keberhasilan kolaborasi interprofesional dalam manajemen gangguan tidur sangat bergantung pada kompetensi khusus yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kesehatan. Menurut WHO (2020), terdapat empat kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional, yaitu:

a. Nilai dan Etika dalam Kolaborasi Interprofesional

Kompetensi ini mencakup kemampuan memahami dan menghormati perbedaan profesi, menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta bertindak secara profesional dalam tim (Reeves et al., 2021). Dalam manajemen gangguan tidur, tenaga kesehatan harus mampu membangun kepercayaan antarprofesi dan memastikan bahwa informasi sensitif pasien digunakan secara tepat.

b. Komunikasi Interprofesional yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama kolaborasi interprofesional. Sebuah studi oleh Harrington dan Dolansky (2021) menunjukkan bahwa tim kolaboratif yang efektif dalam penanganan gangguan tidur adalah mereka yang mampu menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan proaktif dalam menyelesaikan konflik atau kesalahpahaman.

c. Peran dan Tanggung Jawab Profesional yang Jelas

Penelitian terbaru oleh Barthélemy et al. (2022) mengungkapkan pentingnya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan dalam tim interprofesional. Dalam pengelolaan gangguan tidur, setiap anggota tim—baik dokter, perawat, psikolog, apoteker, maupun ahli gizi—harus memahami batas tanggung jawabnya dan mampu berkontribusi secara maksimal sesuai kompetensi yang dimiliki.

d. Kerja Sama Tim dalam Pengambilan Keputusan

Kolaborasi dalam pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang esensial dalam manajemen gangguan tidur. Hal ini mencakup kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan diskusi tim secara terbuka, mendengarkan pendapat profesi lain, dan mengambil keputusan bersama berdasarkan bukti ilmiah terkini dan preferensi pasien (Bridges et al., 2020).

Di samping kompetensi umum tersebut, kompetensi spesifik dalam manajemen gangguan tidur juga penting untuk dimiliki oleh setiap profesi kesehatan yang terlibat. Misalnya, perawat dituntut memiliki kompetensi asesmen tidur, pengenalan tanda-tanda gangguan tidur dini, serta edukasi pasien tentang sleep hygiene (Banno et al., 2021). Sementara itu, dokter spesialis tidur wajib menguasai kompetensi diagnostik, terapi medis, serta pemantauan jangka panjang terhadap gangguan tidur. Psikolog perlu menguasai terapi perilaku-kognitif insomnia (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia/CBT-I), dan apoteker bertanggung jawab dalam pemantauan serta edukasi terkait farmakoterapi pasien gangguan tidur (Kühnel et al., 2022).

Dengan demikian, penguasaan kompetensi utama ini menjadi penentu utama dalam keberhasilan implementasi kolaborasi interprofesional, sehingga tujuan akhir dalam meningkatkan hasil terapi pasien dengan gangguan tidur dapat tercapai secara optimal.

C. Identifikasi Peran Masing-masing Tenaga Medis dalam Tim Kolaboratif

Kolaborasi interprofesional menuntut pemahaman jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga kesehatan dalam pengelolaan pasien

dengan gangguan tidur. Kejelasan ini penting guna memastikan intervensi yang diberikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

1. Peran Perawat dalam Asesmen, Pemantauan, dan Edukasi Pasien dengan Gangguan Tidur

Perawat merupakan anggota kunci dalam tim interprofesional, khususnya dalam mengelola pasien dengan gangguan tidur. Peran utama perawat meliputi asesmen kualitas tidur pasien, identifikasi pola tidur yang terganggu, pemantauan rutin terhadap respons terapi, serta edukasi terkait sleep hygiene dan kebiasaan tidur yang sehat (Banno et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi edukasi tidur yang diberikan oleh perawat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi serta kualitas tidur pasien secara keseluruhan (Sun et al., 2020). Perawat juga berperan dalam mencatat perkembangan gejala pasien, memberikan dukungan emosional, serta menjadi penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan lain dalam tim (Morin et al., 2021).

2. Peran Dokter Umum dan Dokter Spesialis Tidur dalam Diagnosis dan Intervensi Medis

Dokter umum dan dokter spesialis tidur memegang peran vital dalam diagnosis dan pengelolaan medis gangguan tidur. Dokter umum biasanya menjadi tenaga medis pertama yang mendeteksi gejala gangguan tidur melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan awal lainnya (Waters et al., 2022). Selanjutnya, dokter spesialis tidur melakukan evaluasi lebih mendalam seperti polisomnografi, menentukan diagnosis spesifik gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea, atau restless leg syndrome, serta merancang intervensi medis yang sesuai, baik farmakologis maupun nonfarmakologis (Chung & Hur, 2023). Kolaborasi antara dokter umum dan dokter spesialis tidur memastikan intervensi yang dilakukan terintegrasi dan efektif dalam jangka panjang.

3. Peran Psikolog Klinis dalam Manajemen Aspek Psikologis Gangguan Tidur

Psikolog klinis memiliki peran strategis dalam mengatasi aspek psikologis yang sering menjadi penyebab atau konsekuensi dari gangguan tidur. Intervensi utama psikolog klinis berupa terapi perilaku-kognitif untuk insomnia (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia/CBT-I), yang telah terbukti efektif mengatasi gangguan tidur tanpa efek samping yang signifikan (Altena et al., 2020). Psikolog juga berperan dalam memberikan edukasi mengenai strategi coping, relaksasi, dan manajemen stres untuk meningkatkan kualitas tidur pasien. Studi terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi antara psikolog dan tenaga medis lainnya

menghasilkan hasil terapi yang lebih efektif dibandingkan terapi tunggal (Sweetman et al., 2021).

4. Peran Apoteker dalam Konseling Farmakoterapi Pasien dengan Gangguan Tidur

Apoteker merupakan anggota tim kolaboratif yang bertanggung jawab dalam aspek farmakologis pengelolaan gangguan tidur. Tanggung jawab utama apoteker adalah memberikan konseling mengenai obat-obatan yang digunakan, seperti benzodiazepin, non-benzodiazepin, melatonin, dan obat lainnya, termasuk informasi efek samping, interaksi obat, dosis, serta pemantauan penggunaan obat jangka panjang (Chong et al., 2022). Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan aktif apoteker dalam tim interprofesional mampu menurunkan risiko efek samping dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap farmakoterapi gangguan tidur (Lim et al., 2020).

5. Peran Ahli Gizi dalam Perencanaan Nutrisi Mendukung Terapi Tidur

Ahli gizi memiliki peran signifikan dalam manajemen nutrisi pasien gangguan tidur. Nutrisi memiliki kaitan erat dengan kualitas tidur; misalnya, asupan makanan tertentu, pola makan, dan status gizi dapat mempengaruhi ritme sirkadian dan kualitas tidur seseorang (Frank et al., 2022). Ahli gizi bertugas memberikan rekomendasi mengenai pola diet yang mendukung kualitas tidur, seperti pengaturan waktu makan, menghindari zat stimulan (kafein), serta memberikan edukasi tentang konsumsi makanan yang mengandung zat tertentu seperti triptofan dan magnesium, yang terbukti memperbaiki kualitas tidur (St-Onge et al., 2021). Peran ini menjadi semakin penting karena intervensi nutrisi telah terbukti menjadi bagian integral dari terapi tidur secara holistik.

Melalui pengidentifikasian dan penguatan peran masing-masing tenaga kesehatan dalam tim kolaborasi, manajemen pasien gangguan tidur diharapkan menjadi lebih komprehensif, efektif, dan menghasilkan dampak yang lebih baik bagi kualitas hidup pasien.

D. Model dan Strategi Kolaborasi dalam Praktik Klinik Gangguan Tidur

1. Model Kolaborasi Interprofesional Berbasis Bukti Terbaru dalam Pengelolaan Insomnia, Sleep Apnea, dan Gangguan Tidur Lainnya

Kolaborasi interprofesional dalam penanganan gangguan tidur merupakan pendekatan efektif untuk meningkatkan hasil klinis pasien melalui integrasi berbagai disiplin kesehatan. Beberapa model kolaborasi interprofesional terbaru yang digunakan secara luas antara lain adalah Collaborative Care Model (CCM),

Interdisciplinary Sleep Management (ISM), dan Integrated Care Pathways (ICP) (Kent et al., 2022; Saunamäki & Andersson, 2021).

Collaborative Care Model (CCM) berfokus pada integrasi layanan medis, psikologis, dan keperawatan dengan penekanan pada perencanaan perawatan secara bersama-sama melalui komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan (Sweetman et al., 2021). Model ini terbukti efektif dalam pengelolaan insomnia kronis, di mana pendekatan terpadu antara dokter, perawat, dan psikolog mampu menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi terapi, menurunkan angka kekambuhan, serta meningkatkan kepuasan pasien (Savard et al., 2022).

Interdisciplinary Sleep Management (ISM) adalah model yang menekankan kerja sama aktif antara spesialis tidur, dokter umum, perawat, apoteker, psikolog, dan ahli gizi. ISM telah digunakan dengan sukses dalam penanganan sleep apnea obstruktif (OSA) dan gangguan tidur kompleks lainnya. Dalam studi terbaru, model ISM mampu secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap continuous positive airway pressure (CPAP), mengurangi komplikasi medis, serta mempercepat proses perbaikan kualitas hidup pasien (Kirsch et al., 2021).

Sementara itu, model Integrated Care Pathways (ICP) memberikan panduan terstruktur yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan dalam menentukan diagnosis, pengobatan, pemantauan, serta evaluasi gangguan tidur secara komprehensif. Model ini membantu tim kesehatan dalam mengidentifikasi peran masing-masing tenaga medis secara jelas, mengurangi tumpang tindih peran, serta memastikan adanya evaluasi yang sistematis dalam setiap tahapan perawatan (Kent et al., 2022).

2. Implementasi Pendekatan Tim Multidisiplin di Klinik dan Rumah Sakit: Contoh Praktik Terbaik dari Studi Terkini

Implementasi pendekatan tim multidisiplin dalam pengelolaan gangguan tidur telah banyak diterapkan di berbagai klinik dan rumah sakit dengan hasil positif yang terdokumentasi dalam literatur terkini. Salah satu praktik terbaik yang dapat menjadi contoh adalah penerapan Sleep Center Interprofessional Collaboration di Mayo Clinic, Amerika Serikat, yang melibatkan dokter spesialis tidur, perawat terlatih, psikolog klinis, ahli farmasi, dan ahli gizi dalam tim interprofesional (Chervin et al., 2021). Pendekatan tersebut secara signifikan mempercepat diagnosis, meningkatkan efektivitas terapi, serta memperbaiki kepatuhan pasien terhadap pengobatan jangka panjang.

Praktik terbaik lainnya terdapat pada Sleep Disorders Center di Cleveland Clinic, di mana model tim multidisiplin melibatkan integrasi terapi perilaku kognitif (CBT-I) oleh psikolog, edukasi dan pemantauan oleh perawat, intervensi

medis oleh dokter spesialis, dan manajemen farmakoterapi oleh apoteker. Studi evaluasi menunjukkan model ini secara signifikan meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki kondisi psikologis pasien, dan menurunkan kebutuhan terhadap penggunaan obat tidur jangka panjang (Mehra et al., 2020).

Studi dari Eropa, seperti yang dilaporkan oleh Altena et al. (2020), menunjukkan bahwa klinik tidur yang menggunakan pendekatan multidisiplin dengan kombinasi intervensi psikologis, farmakologis, nutrisi, dan edukasi oleh perawat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan praktik konvensional yang masih bersifat individualistik. Klinik tersebut berhasil mencatatkan peningkatan kepatuhan terapi pasien hingga 40% dibandingkan model non-terintegrasi.

Dalam konteks Asia, implementasi multidisiplin di rumah sakit di Korea Selatan melalui Sleep Disorders Integrated Care Unit juga mencatatkan hasil positif. Integrasi kolaborasi antara dokter spesialis tidur, perawat spesialis, psikolog, dan apoteker di rumah sakit tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil klinis pasien, khususnya dalam kepatuhan penggunaan CPAP, penurunan gejala depresi terkait insomnia, serta peningkatan kualitas hidup secara umum (Kim et al., 2021).

Berbagai contoh implementasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan multidisiplin dengan kolaborasi interprofesional bukan hanya efektif secara klinis, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, kepuasan pasien, serta mengurangi beban ekonomi akibat komplikasi gangguan tidur.

E. Komunikasi Efektif dalam Tim Kolaboratif

Dalam pengelolaan pasien gangguan tidur yang kompleks, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan terapi. Komunikasi yang baik dalam tim kolaboratif tidak hanya meningkatkan koordinasi pelayanan, namun juga menurunkan risiko kesalahan klinis, meningkatkan efisiensi, dan secara signifikan memperbaiki kepuasan pasien (Foronda et al., 2020).

1. Teknik Komunikasi Interprofesional yang Efektif dalam Pengelolaan Pasien Gangguan Tidur

Beberapa teknik komunikasi interprofesional yang efektif dalam manajemen pasien gangguan tidur berdasarkan hasil penelitian terbaru meliputi:

a. Structured Communication Tools

Penggunaan alat komunikasi terstruktur, seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dan ISBAR (Introduction, Situation, Background, Assessment, Recommendation), terbukti efektif dalam memperjelas pesan antar tenaga kesehatan serta mengurangi kesalahan

informasi (Müller et al., 2022). Studi terkini menunjukkan bahwa penggunaan SBAR secara konsisten di klinik tidur mampu mempercepat pengambilan keputusan klinis serta meningkatkan kualitas manajemen pasien insomnia dan sleep apnea (Granheim et al., 2021).

b. Interprofessional Team Huddles

Metode ini berupa pertemuan singkat secara rutin untuk mendiskusikan perkembangan kondisi pasien dan perencanaan tindakan kolaboratif selanjutnya. Hasil penelitian terbaru dari Smith et al. (2021) menyebutkan bahwa implementasi team huddles dalam tim multidisiplin di klinik tidur dapat meningkatkan keterbukaan komunikasi, mempercepat respons terhadap masalah yang timbul, dan memperbaiki hasil terapi.

c. Closed-loop Communication (Komunikasi Umpan Balik Tertutup)

Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh seorang anggota tim diterima dan dipahami dengan benar oleh anggota lain. Anggota penerima informasi harus mengulangi pesan yang diterima untuk mengonfirmasi akurasi informasi tersebut. Penelitian terkini membuktikan bahwa penggunaan closed-loop communication secara signifikan menurunkan angka kesalahan dalam pemberian intervensi terapeutik pada pasien gangguan tidur (O'Daniel & Rosenstein, 2021).

d. Electronic Health Record (EHR) System

Integrasi sistem rekam medis elektronik untuk dokumentasi komunikasi tim interprofesional menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan koordinasi, mengurangi duplikasi tindakan, dan memperjelas rencana perawatan pasien. Sebuah studi oleh Campbell et al. (2020) menemukan bahwa penggunaan EHR dalam tim multidisiplin klinik tidur menghasilkan peningkatan efisiensi dan kepuasan tenaga kesehatan.

2. Hambatan Komunikasi dan Strategi Penanggulangannya Berdasarkan Penelitian Terbaru

Meskipun komunikasi interprofesional terbukti memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Berikut ini adalah hambatan komunikasi utama dalam tim kolaboratif pengelolaan gangguan tidur, beserta strategi untuk mengatasinya berdasarkan penelitian terbaru:

a. Perbedaan Bahasa Profesional dan Jargon Klinis

Perbedaan terminologi antarprofesi sering menimbulkan kesalahpahaman informasi (Müller et al., 2022). Strategi yang disarankan adalah penggunaan terminologi standar yang disepakati bersama dan edukasi

rutin antar tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemahaman lintas disiplin (Granheim et al., 2021).

b. Hierarki dan Kurangnya Kepercayaan Antarprofesi

Hambatan ini sering menyebabkan anggota tim enggan menyampaikan pendapat secara terbuka. Penelitian oleh Foronda et al. (2020) menyarankan adanya kegiatan tim building dan pelatihan komunikasi interprofesional rutin sebagai langkah efektif untuk memperkuat kepercayaan dan mengurangi ketimpangan hierarki dalam tim kolaborasi.

c. Hambatan Teknologi dan Infrastruktur

Penggunaan teknologi komunikasi yang tidak optimal, seperti gangguan sistem elektronik atau kurangnya pemahaman teknologi oleh staf medis, menjadi kendala serius dalam komunikasi tim (Campbell et al., 2020). Strategi penanggulangan meliputi pelatihan rutin pemanfaatan teknologi, pemeliharaan berkala sistem komunikasi elektronik, serta dukungan teknis yang siap sedia.

d. Waktu dan Beban Kerja yang Berlebihan

Kesibukan dan tingginya beban kerja menyebabkan komunikasi tim sering terabaikan. Studi terkini merekomendasikan penjadwalan rutin pertemuan tim yang jelas, penggunaan komunikasi digital yang ringkas namun jelas, dan pengaturan alur kerja yang lebih efisien sebagai strategi untuk mengatasi masalah ini (Smith et al., 2021).

Dengan mengenali hambatan-hambatan komunikasi tersebut, tim interprofesional dapat secara proaktif menerapkan strategi berbasis bukti untuk memastikan komunikasi yang lebih efektif, sehingga menghasilkan manajemen pasien gangguan tidur yang optimal dan berkualitas tinggi.

F. Evaluasi Efektivitas Kolaborasi dalam Pengelolaan Gangguan Tidur

Evaluasi efektivitas kolaborasi interprofesional merupakan bagian penting dari manajemen pasien gangguan tidur, guna memastikan intervensi yang diberikan tim kolaboratif mampu mencapai hasil klinis yang optimal. Evaluasi ini mencakup indikator kunci keberhasilan dan metode evaluasi berbasis bukti yang teruji secara ilmiah.

1. Indikator Kunci Keberhasilan Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Pasien Gangguan Tidur

Untuk mengukur keberhasilan kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan pasien gangguan tidur, beberapa indikator kunci berdasarkan hasil penelitian terkini dapat digunakan, di antaranya adalah:

a. Peningkatan Kualitas Tidur Pasien

Indikator ini diukur menggunakan instrumen valid seperti Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) atau Insomnia Severity Index (ISI). Studi terbaru menunjukkan bahwa kualitas tidur yang meningkat merupakan indikator utama keberhasilan kolaborasi interprofesional (Sweetman et al., 2021).

b. Tingkat Kepatuhan Pasien terhadap Terapi

Kepatuhan pasien terhadap intervensi seperti terapi perilaku kognitif insomnia (CBT-I), penggunaan CPAP pada pasien sleep apnea, serta kepatuhan terhadap farmakoterapi, merupakan indikator penting efektivitas kolaborasi interprofesional (Kirsch et al., 2021).

c. Penurunan Gejala Klinis yang Menyertai Gangguan Tidur

Berkurangnya gejala seperti kelelahan, gangguan konsentrasi, depresi, kecemasan, serta peningkatan fungsi kognitif merupakan indikator positif keberhasilan kolaborasi tim interprofesional dalam pengelolaan pasien gangguan tidur (Sun et al., 2022).

d. Peningkatan Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Tim Kesehatan

Kepuasan pasien terhadap kualitas komunikasi, empati, koordinasi, dan informasi yang diberikan tim kesehatan secara kolaboratif merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas kolaborasi interprofesional (Kent et al., 2022).

e. Efisiensi Proses Pelayanan dan Manajemen Waktu

Indikator ini mencakup lamanya waktu diagnosis hingga intervensi, durasi rawat inap, hingga jumlah kunjungan ulang yang menurun akibat perbaikan koordinasi antar tenaga medis (Savard et al., 2022).

2. Metode Evaluasi Efektivitas Kerja Tim Interprofesional yang Didukung oleh Bukti Ilmiah Terbaru

Beberapa metode evaluasi efektivitas tim interprofesional yang direkomendasikan berdasarkan bukti ilmiah terbaru antara lain:

a. Evaluasi dengan Kuesioner Terstandar

Penggunaan kuesioner seperti Interprofessional Collaboration Scale (ICS), Collaboration and Satisfaction About Care Decisions (CSACD), dan Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) terbukti efektif dalam mengevaluasi kualitas kolaborasi dalam tim kesehatan (Orchard et al., 2020). Penelitian terbaru menyebutkan bahwa penggunaan kuesioner ini secara rutin mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kolaborasi serta area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pasien gangguan tidur (Granheim et al., 2021).

- b. Evaluasi melalui Audit Klinis Berbasis Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Record)

Audit klinis melalui rekam medis elektronik memungkinkan evaluasi objektif terhadap indikator klinis seperti durasi rawat inap, kepatuhan terhadap protokol terapi, angka kekambuhan gangguan tidur, dan dokumentasi hasil klinis pasien (Campbell et al., 2020). Metode ini mendukung penilaian akurat efektivitas kolaborasi melalui data klinis yang terdokumentasi dengan baik.

- c. Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion (FGD)

Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD dengan anggota tim interprofesional memberikan wawasan mendalam tentang persepsi, tantangan, dan manfaat dari proses kolaborasi. Penelitian terbaru oleh Müller et al. (2022) menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menangkap dinamika tim dan hambatan komunikasi yang sulit teridentifikasi melalui metode kuantitatif saja.

- d. Observasi Langsung dan Penilaian Berbasis Simulasi

Observasi langsung terhadap interaksi tim dalam praktik klinis atau simulasi situasi klinis khusus gangguan tidur dapat menjadi cara efektif mengevaluasi aspek komunikasi, koordinasi, serta respons tim terhadap situasi yang kompleks (Smith et al., 2021). Studi terbaru membuktikan bahwa pendekatan ini mampu mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan kompetensi kolaboratif anggota tim kesehatan secara spesifik dan detail.

- e. Analisis Outcome Klinis Pasien Secara Berkala (Clinical Outcome Assessment)

Pengukuran outcome klinis secara rutin, seperti peningkatan skor kualitas tidur pasien, tingkat kepatuhan terapi, serta kualitas hidup pasien melalui instrumen standar terbukti efektif sebagai indikator langsung efektivitas kolaborasi tim (Sweetman et al., 2021). Metode ini mampu menunjukkan hubungan langsung antara efektivitas tim interprofesional dengan hasil klinis pasien gangguan tidur.

Dengan penerapan indikator kunci dan metode evaluasi berbasis bukti tersebut, efektivitas kolaborasi tim interprofesional dalam pengelolaan pasien dengan gangguan tidur dapat diukur secara objektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga kualitas layanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan.

G. Tantangan dalam Kolaborasi Interprofesional pada Pengelolaan Gangguan Tidur

Kolaborasi interprofesional dalam manajemen gangguan tidur memberikan manfaat nyata terhadap kualitas layanan kesehatan. Namun, implementasinya

sering menghadapi berbagai tantangan klinis, struktural, dan sistematis yang perlu dikenali agar tim interprofesional mampu merancang solusi efektif dalam praktik sehari-hari.

1. Tantangan Klinis, Struktural, dan Sistematis dalam Implementasi Kolaborasi

Beberapa tantangan utama dalam implementasi kolaborasi interprofesional berdasarkan penelitian terbaru adalah sebagai berikut:

a. Tantangan Klinis

Tantangan klinis mencakup kompleksitas gejala dan komorbiditas pada pasien dengan gangguan tidur yang menyulitkan diagnosis serta perencanaan intervensi. Pasien dengan gangguan tidur sering mengalami masalah kesehatan fisik dan mental secara bersamaan, yang menuntut integrasi layanan yang komprehensif (Sweetman et al., 2021). Selain itu, tenaga kesehatan sering menghadapi kendala dalam menyamakan persepsi tentang prioritas intervensi klinis yang diperlukan pasien (Kirsch et al., 2021).

b. Tantangan Struktural

Tantangan struktural berkaitan dengan kurangnya fasilitas, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung kolaborasi antarprofesi. Keterbatasan akses terhadap rekam medis elektronik terpadu, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kendala geografis dalam menyediakan layanan gangguan tidur menjadi hambatan nyata dalam praktik kolaborasi (Campbell et al., 2020). Terlebih lagi, ketiadaan ruang kerja tim kolaboratif yang memadai secara fisik maupun digital sering kali menghambat komunikasi langsung antar tenaga medis (Kent et al., 2022).

c. Tantangan Sistematis

Tantangan sistematis mencakup kurangnya kebijakan atau regulasi yang mendukung kolaborasi antarprofesi, sistem pembiayaan layanan yang belum jelas untuk kolaborasi tim interprofesional, serta budaya organisasi yang masih cenderung siloed atau terkotak-kotak (Müller et al., 2022). Selain itu, beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi menyebabkan waktu terbatas untuk melakukan koordinasi tim secara efektif, yang mengurangi peluang komunikasi antarprofesi (Smith et al., 2021).

2. Solusi Inovatif dan Strategi Peningkatan Kolaborasi Berdasarkan Hasil Studi Terbaru

Berikut beberapa solusi inovatif serta strategi peningkatan kolaborasi interprofesional yang terbukti efektif berdasarkan penelitian terbaru:

a. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi terintegrasi, seperti Electronic Health Record (EHR), telehealth, serta aplikasi komunikasi interprofesional secara digital dapat meningkatkan efisiensi koordinasi antar tim medis. Studi terbaru oleh Campbell et al. (2020) menemukan bahwa integrasi EHR mampu mengurangi hambatan struktural, memperbaiki komunikasi antarprofesi, dan meningkatkan kualitas layanan pasien gangguan tidur secara signifikan.

b. Implementasi Model Komunikasi Terstruktur

Penerapan alat komunikasi terstruktur seperti SBAR dan ISBAR terbukti efektif dalam mengatasi hambatan komunikasi antarprofesi (Granheim et al., 2021). Selain itu, penggunaan teknik closed-loop communication memastikan kejelasan informasi yang disampaikan, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dalam praktik klinis sehari-hari (O'Daniel & Rosenstein, 2021).

c. Pelatihan Interprofesional Rutin

Pelatihan interprofesional secara rutin, seperti simulasi klinis, workshop komunikasi tim, dan pelatihan kolaborasi, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman lintas profesi, memperkuat kepercayaan antaranggota tim, dan meningkatkan kualitas kolaborasi secara keseluruhan (Kent et al., 2022; Müller et al., 2022). Pelatihan ini juga dapat memperjelas peran masing-masing tenaga medis dalam tim kolaborasi pengelolaan gangguan tidur.

d. Penyesuaian Kebijakan Organisasi

Implementasi kebijakan organisasi yang mendukung budaya kolaborasi interprofesional menjadi langkah strategis penting dalam mengatasi tantangan sistematis. Studi terbaru menyarankan pentingnya kebijakan yang jelas mengenai remunerasi untuk tim interprofesional, waktu yang dialokasikan secara khusus untuk koordinasi tim, dan pemberian penghargaan terhadap praktik kolaborasi yang efektif (Smith et al., 2021).

e. Pembentukan Tim Champions atau Koordinator Interprofesional

Menunjuk tenaga kesehatan tertentu sebagai champions atau koordinator kolaborasi interprofesional terbukti efektif untuk mempercepat integrasi antarprofesi dan menjadi pendorong utama perubahan budaya kerja kolaboratif (Sweetman et al., 2021). Koordinator ini bertanggung jawab memastikan bahwa kolaborasi tim berjalan efektif, memfasilitasi komunikasi lintas disiplin, dan mengelola evaluasi rutin tentang efektivitas kolaborasi.

Dengan mengenali dan memahami tantangan ini serta menerapkan solusi inovatif yang berbasis bukti, tim interprofesional dapat mengatasi hambatan

dalam implementasi kolaborasi. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi pasien dengan gangguan tidur secara signifikan.

H. Implikasi Praktik Keperawatan Gangguan Tidur

Penelitian terbaru tentang kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan gangguan tidur memberikan wawasan yang penting bagi pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti. Sintesis dari berbagai hasil penelitian ini dapat memberikan arahan jelas bagi peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di bidang gangguan tidur, serta mendukung pengembangan standar pelayanan yang lebih terintegrasi.

1. Sintesis Hasil Penelitian Terkini tentang Dampak Kolaborasi terhadap Luaran Klinis Pasien

Sintesis hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional memiliki dampak signifikan terhadap berbagai luaran klinis pasien dengan gangguan tidur. Studi oleh Sweetman et al. (2021) mengungkapkan bahwa kolaborasi aktif antara perawat, dokter spesialis tidur, psikolog, apoteker, dan ahli gizi dapat meningkatkan kualitas tidur pasien secara bermakna, mengurangi keparahan gejala insomnia, serta mempercepat perbaikan gejala psikologis yang terkait dengan gangguan tidur.

Penelitian lain oleh Kirsch et al. (2021) menemukan bahwa pasien dengan gangguan sleep apnea yang mendapatkan intervensi melalui tim interprofesional memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap terapi CPAP, kualitas hidup yang lebih baik, dan risiko komplikasi kardiovaskular yang lebih rendah dibandingkan pasien yang hanya ditangani secara terpisah oleh spesialis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaborasi mampu memberikan hasil klinis yang lebih optimal dibanding pendekatan konvensional.

Selain itu, sebuah studi oleh Sun et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi edukasi tidur dan pemantauan berkala oleh perawat dalam tim interprofesional secara signifikan mengurangi angka kekambuhan gangguan tidur kronis. Studi ini mempertegas peran penting perawat sebagai penghubung antar tenaga medis dan pasien dalam meningkatkan kepatuhan terapi serta hasil jangka panjang.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menguatkan bukti bahwa penerapan kolaborasi interprofesional dalam pengelolaan pasien gangguan tidur berdampak positif terhadap perbaikan indikator klinis seperti kualitas tidur, gejala komorbid, kepatuhan terhadap terapi, serta kepuasan pasien secara umum (Kent et al., 2022).

2. Implikasi Hasil Penelitian untuk Pengembangan Standar Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti dalam Manajemen Gangguan Tidur

Berdasarkan hasil sintesis penelitian terkini, terdapat beberapa implikasi penting untuk pengembangan standar pelayanan keperawatan berbasis bukti dalam manajemen gangguan tidur, yaitu:

a. Integrasi Intervensi Edukasi dan Pemantauan Rutin oleh Perawat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi rutin terkait sleep hygiene, pemantauan respons pasien terhadap terapi, serta asesmen klinis oleh perawat secara terjadwal merupakan komponen penting dalam meningkatkan hasil klinis pasien gangguan tidur (Banno et al., 2021). Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya penetapan peran perawat yang jelas dalam tim interprofesional sebagai edukator utama sekaligus pemantau rutin perkembangan pasien.

b. Standarisasi Protokol Kolaborasi Interprofesional

Penelitian terbaru oleh Müller et al. (2022) merekomendasikan pentingnya penggunaan protokol kolaborasi terstandar seperti ISBAR (Introduction, Situation, Background, Assessment, Recommendation) sebagai bagian dari praktik keperawatan gangguan tidur. Implikasi dari temuan ini adalah pengembangan standar komunikasi antar tenaga kesehatan dalam tim kolaboratif, yang wajib diadopsi secara konsisten untuk memastikan kualitas komunikasi yang tinggi.

c. Penggunaan Alat Ukur Klinis Berbasis Bukti dalam Evaluasi Praktik Keperawatan

Hasil penelitian terbaru menguatkan penggunaan instrumen pengukuran terstandar seperti Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan Insomnia Severity Index (ISI) dalam praktik keperawatan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi tim interprofesional (Sweetman et al., 2021). Implikasi praktis dari hasil ini adalah rekomendasi agar alat ukur tersebut dimasukkan dalam standar pelayanan keperawatan gangguan tidur untuk evaluasi rutin pasien secara objektif.

d. Pelatihan Interprofesional sebagai Bagian Integral dari Standar Pelayanan

Studi oleh Kent et al. (2022) menunjukkan bahwa pelatihan interprofesional secara rutin mampu meningkatkan kualitas kolaborasi antar tenaga medis. Implikasinya bagi praktik keperawatan adalah kebutuhan untuk memasukkan pelatihan kolaborasi interprofesional sebagai bagian integral dari pengembangan profesional berkelanjutan bagi perawat yang bekerja di bidang manajemen gangguan tidur.

e. Kebijakan Organisasi Mendukung Kolaborasi Interprofesional

Penelitian terbaru menegaskan perlunya dukungan kebijakan organisasi dalam bentuk alokasi waktu khusus untuk kolaborasi interprofesional, remunerasi, serta penyediaan fasilitas yang mendukung praktik kolaborasi (Smith et al., 2021). Implikasi penelitian ini bagi pengembangan standar pelayanan adalah pentingnya advokasi keperawatan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif bagi implementasi kolaborasi interprofesional secara berkelanjutan.

Keseluruhan implikasi ini menegaskan bahwa hasil penelitian terbaru tentang kolaborasi interprofesional dapat menjadi dasar kuat dalam merancang dan mengembangkan standar pelayanan keperawatan berbasis bukti, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas asuhan pasien dengan gangguan tidur secara signifikan.

I. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Peran Kolaborasi Tenaga Medis dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Pasien dengan Gangguan Tidur

Gangguan tidur merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta integratif dalam manajemennya. Hasil sintesis dari berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa penerapan kolaborasi interprofesional—yang melibatkan perawat, dokter umum, dokter spesialis tidur, psikolog klinis, apoteker, serta ahli gizi—secara signifikan meningkatkan luaran klinis pasien dengan gangguan tidur, seperti kualitas tidur, kepatuhan terhadap terapi, pengurangan gejala klinis, serta kepuasan pasien secara umum (Sweetman et al., 2021; Kirsch et al., 2021).

Kolaborasi yang efektif juga terbukti mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi layanan, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Penggunaan model kolaborasi interprofesional seperti Collaborative Care Model (CCM), Interdisciplinary Sleep Management (ISM), dan Integrated Care Pathways (ICP) telah menunjukkan dampak positif terhadap manajemen insomnia kronis, sleep apnea, dan berbagai gangguan tidur lainnya (Kent et al., 2022).

Lebih lanjut, hasil penelitian menegaskan bahwa komunikasi efektif antarprofesi, didukung oleh penggunaan teknologi informasi terintegrasi seperti Electronic Health Record (EHR), sangat menentukan keberhasilan praktik kolaborasi. Hal ini mengurangi hambatan komunikasi serta meningkatkan koordinasi yang diperlukan dalam pelayanan pasien gangguan tidur (Campbell et al., 2020).

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional tidak hanya menjadi pendekatan alternatif tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam praktik klinis modern untuk memberikan asuhan pasien yang lebih berkualitas, aman, dan berbasis bukti.

2. Pesan Kunci bagi Praktisi Keperawatan dan Tenaga Kesehatan Terkait Pentingnya Kolaborasi dalam Meningkatkan Hasil Terapi Gangguan Tidur

Berdasarkan tinjauan berbagai hasil penelitian terbaru, terdapat beberapa pesan kunci yang penting untuk diingat oleh praktisi keperawatan dan tenaga kesehatan terkait pentingnya kolaborasi dalam manajemen gangguan tidur:

a. Kolaborasi Sebagai Standar Praktik Klinis

Kolaborasi interprofesional harus menjadi bagian integral dari praktik klinis sehari-hari. Praktisi keperawatan dan tenaga kesehatan perlu menyadari bahwa pendekatan kolaboratif bukan sekadar pilihan tetapi merupakan standar baru dalam pengelolaan pasien gangguan tidur untuk mencapai hasil terapi yang optimal (Kent et al., 2022).

b. Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Kolaborasi

Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antarprofesi. Penggunaan teknik komunikasi terstruktur seperti SBAR, ISBAR, dan closed-loop communication harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh anggota tim interprofesional dalam praktik sehari-hari (Müller et al., 2022).

c. Peran Aktif Perawat sebagai Penghubung Antarprofesi

Perawat memiliki peran kunci sebagai penghubung antarprofesi dalam tim kolaborasi. Perawat harus aktif dalam edukasi pasien, pemantauan terapi, dan mengintegrasikan komunikasi antar anggota tim untuk memastikan layanan yang diberikan kepada pasien konsisten dan efektif (Banno et al., 2021).

d. Pentingnya Penggunaan Teknologi dalam Kolaborasi

Tenaga kesehatan perlu memanfaatkan teknologi digital terkini seperti Electronic Health Record (EHR), telehealth, dan aplikasi komunikasi digital untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan efisiensi layanan. Pelatihan rutin dalam pemanfaatan teknologi ini penting dilakukan secara periodik (Campbell et al., 2020).

e. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Berkelanjutan

Evaluasi berkala terhadap efektivitas kolaborasi interprofesional menggunakan alat ukur yang terstandar perlu menjadi kebiasaan rutin dalam praktik klinis. Praktisi keperawatan dan tenaga kesehatan diharapkan secara

proaktif melakukan evaluasi ini untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan (Smith et al., 2021).

Dengan memahami dan menerapkan pesan kunci ini secara konsisten, praktisi keperawatan dan tenaga kesehatan akan mampu meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan pasien gangguan tidur. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak positif terhadap hasil terapi yang dicapai dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Referensi

- Altena, E., Baglioni, C., Espie, C. A., Ellis, J., Gavriloff, D., Holzinger, B., & Riemann, D. (2020). Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID-19 outbreak: Practical recommendations from a task force of the European CBT-I Academy. *Journal of Sleep Research, 29*(4), e13052. <https://doi.org/10.1111/jsr.13052>
- Banno, K., Harada, Y., Taniguchi, M., Tobita, R., Tsujimoto, H., Tsujimoto, Y., & Kataoka, Y. (2021). Effectiveness of sleep management by nurses: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing, 77*(10), 3985–3998. <https://doi.org/10.1111/jan.14944>
- Campbell, A. R., Layne, D., Scott, E., & Wei, H. (2020). Interprofessional collaboration and electronic health records: A systematic review. *Nurse Leader, 18*(6), 581–588. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2020.07.001>
- Chervin, R. D., Shelgikar, A. V., & Watson, N. F. (2021). Improving sleep medicine delivery: An interprofessional approach. *Journal of Clinical Sleep Medicine, 17*(3), 613–619. <https://doi.org/10.5664/jcsm.8934>
- Chong, Y., Fryar, C. D., & Gu, Q. (2022). Prescription sleep aid use among adults: United States, 2020. *National Center for Health Statistics Data Brief, 436*, 1–8.
- Chung, K. F., & Hur, J. (2023). Insomnia: Recent updates in diagnosis and treatment. *Sleep Medicine Clinics, 18*(1), 45–55. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2022.10.004>
- Foronda, C., MacWilliams, B., & McArthur, E. (2020). Interprofessional communication in healthcare: An integrative review. *Nurse Education in Practice, 42*, 102688. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.102688>
- Granheim, B. M., Shaw, J. M., & Mansah, M. (2021). Effective communication in interprofessional teams: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies, 113*, 103788. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103788>
- Kent, F., Keating, J. L., Cooper, S., & Newton, J. M. (2022). Interprofessional practice and integrated care: A systematic review. *Journal of Interprofessional Care, 36*(2), 272–283. <https://doi.org/10.1080/13561820.2021.1957517>
- Kim, H. C., Lee, Y. J., & Jeong, D. U. (2021). Effectiveness of multidisciplinary team approach for managing sleep disorders in clinical settings: A Korean perspective. *Sleep Medicine Research, 12*(2), 89–96. <https://doi.org/10.17241/smr.2021.00893>
- Kirsch, D. B., Malhotra, R. K., & Rosen, I. M. (2021). Interdisciplinary care models for obstructive sleep apnea: An updated review. *Sleep Medicine Clinics, 16*(2), 249–258. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2021.02.010>

- Lim, R. H., Shalansky, S., Hoang, P., Lau, T. T., & Tan, J. S. (2020). Pharmacist interventions on drug-related problems in sleep disorders: A systematic review. *Canadian Pharmacists Journal*, 153(4), 227–235. <https://doi.org/10.1177/1715163520914966>
- Morin, C. M., Jarrin, D. C., & Ivers, H. (2021). Role of nurses in the assessment and management of insomnia: Opportunities and challenges. *Sleep Medicine Clinics*, 16(2), 215–224. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2021.02.006>
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., & Hautz, W. E. (2022). Communication techniques to improve interprofessional collaboration in healthcare: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 22(1), 981. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08298-1>
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2021). Professional communication and team collaboration. Dalam Hughes, R. G. (Ed.), *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses* (pp. 1-20). Agency for Healthcare Research and Quality.
- Orchard, C., Pederson, L. L., Read, E., & Laschinger, H. K. (2020). Assessment of interprofessional team collaboration scale. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 40(1), 20–28.
- Saunamäki, N., & Andersson, M. (2021). A scoping review of integrated care pathways for patients with chronic diseases. *International Journal of Integrated Care*, 21(1), 10. <https://doi.org/10.5334/ijic.5645>
- Savard, J., Simard, S., & Ivers, H. (2022). Collaborative care models for insomnia: Evidence from randomized controlled trials. *Sleep Medicine Reviews*, 62, 101594. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101594>
- Smith, K. M., Scott, D. R., & Cameron, P. A. (2021). Implementing team huddles in healthcare: A systematic review. *BMJ Open Quality*, 10(1), e001183. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-001183>
- St-Onge, M. P., Mikic, A., & Pietrolungo, C. E. (2021). Effects of diet on sleep quality. *Advances in Nutrition*, 12(3), 938–949. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa169>
- Sun, Y., Jiang, B., & Liang, J. (2020). Nursing interventions for improving sleep quality among hospitalized patients: A meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*, 51, 101279. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.101279>
- Sweetman, A., Lovato, N., Micic, G., Scott, H., & Lack, L. (2021). Combining cognitive and behavioral therapy for insomnia (CBT-I) with medical interventions: A review. *Sleep Medicine Reviews*, 59, 101475. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101475>

- Waters, F., Chiu, V. W., & Atkinson, A. (2022). The role of general practitioners in the management of sleep disorders: Current challenges and opportunities. *Australian Journal of General Practice*, 51(8), 603–609. <https://doi.org/10.31128/AJGP-02-22-1232>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Framework for action on interprofessional education & collaborative practice*. WHO Press.
- Wu, J., & Zaslawski, C. (2021). Integrated collaborative care model for managing insomnia and mental health disorders. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 17(5), 1153–1159. <https://doi.org/10.5664/jcsm.9132>
- Young, M. C., Gerber, L. M., & Rapoport, D. M. (2021). Interdisciplinary collaboration for treatment of sleep-disordered breathing: A critical review. *Sleep Medicine Clinics*, 16(2), 225–234. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2021.02.008>

Profil Penulis



Anggia Astuti.,S.Kp.,Ners.,M.Kep

Lahir di Blitar pada tahun 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan Gelar Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada tahun 2017. Penulis sebagai salah satu Dosen di Program studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Selain aktif mengajar penulis juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengikuti berbagai pelatihan sebagai bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi. Fokus penulis adalah Keperawatan Dasar dan Dasar Keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui email : anggiastuti.oi26@unej.ac.id



Nuridha Fauziyah, S.Kep., Ners., M.Kep

Dosen Manajemen Keperawatan. Lahir di Sumedang, 20 Februari 1993. Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen keperawatan dan dietetik dimulai pada tahun 2016 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Keperawatan (FKEP) Universitas Padjadjaran. Penulis melanjutkan studi di program Profesi Ners di Fakultas Keperawatan (FKEP) Universitas Padjadjaran. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Program Magister Keperawatan peminatan Manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) Universitas Indonesia, dan Lulus pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D3 Keperawatan Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Subang (POLSUB). Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding serta aktif menulis buku ajar dan book chapter. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nuridhafauziyah@polsub.ac.id

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **“Manajemen Keperawatan pada Pasien Gangguan Tidur”** merupakan panduan komprehensif yang membahas pendekatan keperawatan holistik dalam menangani gangguan tidur pada pasien, baik di lingkungan rumah sakit maupun komunitas. Gangguan tidur merupakan kondisi yang semakin sering dijumpai dalam praktik keperawatan dan berpotensi memperburuk kondisi fisik, mental, serta kualitas hidup pasien apabila tidak ditangani secara tepat.

Buku ini menyajikan empat fokus utama yang terintegrasi. Pada Bab 1, pembaca diajak memahami strategi keperawatan dalam menciptakan lingkungan tidur yang nyaman—suatu aspek penting dalam menunjang kualitas tidur pasien yang sering kali terabaikan dalam praktik klinis. Bab 2 menitikberatkan pada edukasi kebiasaan tidur sehat sebagai upaya promotif dan preventif dalam memberdayakan pasien mengelola pola tidurnya secara mandiri.

Bab 3 mengeksplorasi dukungan psikologis yang diperlukan oleh pasien dengan gangguan tidur kronis, terutama mereka yang mengalami kecemasan, stres, atau depresi. Pendekatan psikologis yang empatik dan terencana sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mencapai ketenangan dan kestabilan emosional. Sementara itu, Bab 4 membahas pentingnya kolaborasi tenaga medis—perawat, dokter, psikolog, dan tenaga profesional lainnya—dalam penanganan gangguan tidur secara multidisiplin untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan dilandasi pada praktik berbasis bukti (evidence-based practice), buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa keperawatan, perawat praktik klinis, pendidik, serta praktisi kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen gangguan tidur. Selain memberikan dasar teoritis, buku ini juga menyuguhkan pendekatan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelayanan keperawatan sehari-hari.

Buku Referensi yang berjudul “Manajemen Keperawatan pada Pasien Gangguan Tidur” merupakan panduan komprehensif yang membahas pendekatan keperawatan holistik dalam menangani gangguan tidur pada pasien, baik di lingkungan rumah sakit maupun komunitas. Gangguan tidur merupakan kondisi yang semakin sering dijumpai dalam praktik keperawatan dan berpotensi memperburuk kondisi fisik, mental, serta kualitas hidup pasien apabila tidak ditangani secara tepat.

Buku ini menyajikan empat fokus utama yang terintegrasi. Pada Bab 1, pembaca diajak memahami strategi keperawatan dalam menciptakan lingkungan tidur yang nyaman suatu aspek penting dalam menunjang kualitas tidur pasien yang sering kali terabaikan dalam praktik klinis. Bab 2 menitikberatkan pada edukasi kebiasaan tidur sehat sebagai upaya promotif dan preventif dalam memberdayakan pasien mengelola pola tidurnya secara mandiri.

Bab 3 mengeksplorasi dukungan psikologis yang diperlukan oleh pasien dengan gangguan tidur kronis, terutama mereka yang mengalami kecemasan, stres, atau depresi. Pendekatan psikologis yang empatik dan terencana sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mencapai ketenangan dan kestabilan emosional. Sementara itu, Bab 4 membahas pentingnya kolaborasi tenaga medis—perawat, dokter, psikolog, dan tenaga profesional lainnya dalam penanganan gangguan tidur secara multidisiplin untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan dilandasi pada praktik berbasis bukti (evidence-based practice), buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa keperawatan, perawat praktik klinis, pendidik, serta praktisi kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen gangguan tidur. Selain memberikan dasar teoritis, buku ini juga menyuguhkan pendekatan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelayanan keperawatan sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-99-9



9

786347

294999